國立臺灣大學文學院圖書資訊學系

碩士論文

Department of Library and Information Science
College of Liberal Arts
National Taiwan University

Master's Thesis

我該相信誰？
線上評論者資訊對使用者選擇醫師的影響

How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians

陳宇亭
Yu-Ting Chen

指導教授：唐牧群 博士
Advisor: Muh-Chyun Tang, Ph.D.

中華民國 112 年 1 月
January 2023

doi:10.6342/NTU202300441

doi:10.6342/NTU202300441

序言

完成論文的過程，比預期地困難和漫長很多，但也得到超乎預期的豐富收穫。首先，我想先謝謝鄭瑋、天怡、千雯和文蘭老師在我想休學階段曾經給予的鼓勵和建議，謝謝我的指導教授唐牧群老師對題目的開放，讓我能選擇自己真心感興趣的題目。沒有諸位老師的鼓勵，我可能不會展開對研究的探索，也不會開始碩論研究。

在研究的路上，想特別感謝幾位老師於碩班期間對我的照顧和帶給我的啟發，也謝謝相遇的老師帶領我認識圖資、人機互動和研究的各個面向。謝謝鄭瑋老師讓我明白研究可以有千百種樣貌，謝謝天怡老師總是親身示範好的研究者是什麼樣子，謝謝千雯老師讓我發現研究中有趣的一面，謝謝牧群老師讓我知道實驗如何可能。

而論文的完成，最要感謝的，還是唐牧群老師的指導和包容。謝謝老師耐心地指引我如何把好奇轉換為可執行的研究，陪伴我走過從研究發想、設計實驗、執行、分析到寫作的每一個環節，謝謝老師的支持、刺激、鼓勵與包容，讓我能夠在輕鬆無壓力的環境，保持愉快和開放地展開探索。同時，也要感謝兩位口委對計畫書與論文給予的建議和回饋，因為兩位老師的細心審閱和提點，讓我知道自己還有很多不足的地方，也才知道在寫作上還能如何充實和精進。

能在短時間內完成前測和實驗，要感謝協助填寫前測問卷、幫測試實驗流程、實際參與實驗還有轉發招募資訊的所有人。在這邊，想特別謝謝陳容、宛蓉、芯瑜、芳瑀、子源、溫茹、芷瑩、宣志、諄雅、韻琦、家荷、文君、孟儒、彥蓉、程媚、彥竹、雯涵、庭萱、湯慧、詩涵、羽涵、榆真與靖雯於碩論發展各階段的友情贊助、支援和分享，謝謝大家的善意和熱心，讓我得以順利完成實驗和論文。

在學習的路上，想要感謝 R09、R10 和其他一起修課、共事的小夥伴們，因為大家的認真勤奮和在各方面散發的光芒，時不時帶給我一些刺激或啟發，讓我能有不斷向前的動力。也想謝謝威宇學長、世萱學姊、思安學姊和 Amber 學姊帶我認識圖資系上下，友善且熱心地協助解答我的各種疑難雜症。同時，也要感謝宜玲助教、瑜君助教和盈達助教在行政方面提供全方位的諮詢與協助。

在經濟層面，要謝謝系上的工讀機會、鄭瑋老師寫的推薦信和系上的獎學金，還有幾位老師先後提供擔任研究助理的機會，還要感謝阿姨大方的提供住處，讓我不用太煩惱收入問題，可以有更多自主的時間和空間專注在當下。

在情感層面，要謝謝家人和朋友們的陪伴、照顧與包容。謝謝家人讓我在獨立自主生活的同時，也能感受到你們的愛與支持。謝謝朋友們三不五時捎來的關心和打氣，謝謝大家揪吃飯和玩耍，讓我有機會從研究回到人間、出門踏青和認識台北。謝謝幾位好友輪流接住我神秘的情緒起伏，陪我度過陰雨綿綿的無動力時間，或是一起慶祝小小的成就。

在有限的篇幅裡，我想我無法一一細數和感謝在碩班的這兩年半，我獲得多少大家給予的善意、機會、刺激、溫暖、支持和正向回饋，這些種種又如何影響我和幫助我完成碩論研究。正如同沒有完美的寫作，我想也沒有能涵蓋所有感謝的謝辭。最後，想謝謝我還好好活著的好奇心，謝謝自己曾經的努力，謝謝一路上的所有。真心謝謝大家陪我走過這兩年半，和你們同在的時光，都是最好的時光。

doi:10.6342/NTU202300441

doi:10.6342/NTU202300441

摘要

在線上評論尚未普及的年代，大眾多仰賴人際資源管道獲得關於醫師的資訊與推薦，隨著醫師評價網站的出現與能見度的提升，由陌生人撰寫的線上醫師評論也逐漸成為大眾進行醫師選擇決策時重要的參考依據。然而，為了保障病患的隱私，醫師評價網站多採匿名設計，過去即有相關研究發現，匿名性設計會讓使用者較不願意信任和採納評論者的意見。本研究奠基於社會訊息處理理論和社會臨場感理論，探討在匿名的醫師評價網站使用情境中，不同類型的社會線索（身份與經驗線索）會如何影響使用者的感知、信任，及選擇醫師的決策。

本研究採用 2 x 2 x 2 的組內實驗設計，操縱的變項分別為評論者的身份線索（既透露評論者興趣又維持一定匿名性的頭像與評論者的 ID）、經驗線索（評論者於特定主題的評論歷史）與評論效價（正負評）。共招募 80 位近期有使用線上評論經驗的受試者參與實驗。

研究結果發現：身份線索對使用者感知評論者的信任未有直接影響，評論效價會影響使用者對評論者的情感信任，而經驗線索會顯著影響使用者對評論者的認知信任。唯有在正評的情形下，評論可信度才會影響使用者最終的選擇意向。本研究有趣的發現是：身份線索反映的匿名性高低和評論效價之間存在交互作用，在正評的情況下，使用者較信任身份線索相對豐富的評論者，但在負評的情況下，使用者對匿名性較高的評論者有較高程度的信任。

關鍵字：醫師評價網站、社會線索、匿名性、評論效價、情感信任、認知信任、決策判斷

doi:10.6342/NTU202300441

doi:10.6342/NTU202300441

Abstract

With the emergence and popularity of physician review websites, online physician reviews written by strangers have gradually become another decision aid that might greatly impact people's physician selection. However, unlike reviews in other domains, physician review websites are mostly anonymous to protect patient's privacy. Previous studies have shown that anonymity makes users less willing to trust and adopt the opinions of reviewers. Without knowing the true identity of the viewers, the users are left with other judgmental cues to determine the credibility of the reviews. The users might infer the credibility of a review directly by its content, or indirectly by the social cues about the reviewer, which is the main focus of the study. Based on social information processing theory and social presence theory, we hypothesized that different levels of reviewer identity disclosure and review history would impact users' affective and cognitive trust, respectively, which, in turn, would influence their doctor selection.

A total of 80 participants took part in a 2x2x2 within-group experiment where the reviewer's identity disclosure, the reviewer's review history, and the review valence (positive or negative reviews) were manipulated. An imaginary physician review website was created where the participant read reviews of different valences written by reviewers with different levels of disclosure and review history. Their judgment of the reviewer's affective and cognitive trust, along with their choice of the physician were elicited to test the impact of different variables on the user's judgment.

The result showed that the identity cues did not have a direct effect on reviewers' trust, and experience cues can significantly affect users' cognitive trust in reviewers. Review valence also affects users' affective trust. In the case of positive reviews, review credibility has an impact on the user's choice of physician. Interestingly, it was found that the degree of identity cues provided and review valence had an interaction effect on the reviewer's trust.

Keywords: physician review website, social cues, anonymity, review valence, affective trust, cognitive trust, judgment

doi:10.6342/NTU202300441

doi:10.6342/NTU202300441

目錄

序言 ..... **II**

摘要 ..... **IV**

ABSTRACT ..... **VI**

圖目錄 ..... **X**

表目錄 ..... **XII**

第一章　緒論 **1**

第一節　研究背景與動機 1
第二節　研究目的與問題 3
第三節　研究範圍與限制 4

第二章　文獻探討 **5**

第一節　電子口碑 5
第二節　醫師評價網站 10
第三節　從線索到決策 15
第四節　小結 22

第三章　研究方法 **25**

第一節　研究設計 25
第二節　研究對象 26
第三節　研究工具 27
第四節　前測 33
第五節　實驗流程 43
第六節　資料蒐集與分析 50

第四章　研究結果 **51**

第一節　樣本分析 51
第二節　信度分析 52
第三節　相關分析 54
第四節　假設驗證 56
第五節　探索性分析 63
第六節　小結與討論 67

第五章　結論 **75**

第一節　發現與貢獻 75
第二節　實務建議 76
第三節　未來研究方向 78

參考文獻 **81**

doi:10.6342/NTU202300441

附錄一 招募文宣與招募問卷.....93
附錄二 實驗素材範例.....95
附錄三 研究使用量表.....97
附錄四 研究參與者知情同意書.....101

doi:10.6342/NTU202300441

圖目錄

圖 2 - 1 研究假設之模型一 22
圖 2 - 2 研究假設之模型二 23
圖 2 - 3 研究假設之模型三 23
圖 3 - 1 實驗網站頁面功能示意圖 1 28
圖 3 - 2 實驗網站頁面功能示意圖 2 28
圖 3 - 3 實驗網站頁面功能示意圖 3 28
圖 3 - 4 實驗網站控制操作示意 1 29
圖 3 - 5 實驗網站控制操作示意 2 30
圖 3 - 6 實驗網站控制操作示意 3 30
圖 3 - 7 實驗網站控制操作示意 4 30
圖 3 - 8 經驗線索-經驗值高的呈現 38
圖 3 - 9 經驗線索-經驗值低的呈現 38
圖 3 - 10 變項操縱範例 1 42
圖 3 - 11 變項操縱範例 2 42
圖 3 - 12 實驗進行流程 46
圖 3 - 13 實驗網站之首頁 48
圖 3 - 14 實驗網站之搜尋結果頁面醫師列表 48
圖 3 - 15 實驗網站之醫師評論頁面 49
圖 3 - 16 實驗網站之操作流程範例 49
圖 4 - 1 研究假設之模型一 56
圖 4 - 2 中介變項概念示意圖 57
圖 4 - 3 社會臨場感作為中介變項之分析 58
圖 4 - 4 研究假設之模型二 61
圖 4 - 5 研究假設之模型三 62
圖 4 - 6 調節變項概念示意圖 63
圖 4 - 7 身份線索作為調節變項示意圖 64

doi:10.6342/NTU202300441

圖 4 - 8 身份線索與評論效價於情感信任的交互作用 65
圖 4 - 9 身份線索與評論效價於認知信任的交互作用 65
圖 4 - 10 認知信任作為中介變項之分析 66

doi:10.6342/NTU202300441

表目錄

表 3 - 1 研究使用量表題項與來源一覽表 31
表 3 - 2 身份線索前測頭像素材與結果摘要表 34
表 3 - 3 身份線索前測 ID 素材與結果摘要表 36
表 3 - 4 身份線索呈現素材之獨立樣本 T 檢定結果摘要表 36
表 3 - 5 評論內容與評論效價前測素材與結果 39
表 3 - 6 實驗分組 43
表 4 - 1 受試者基本資料 51
表 4 - 2 題項一覽表 52
表 4 - 3 相關分析 55
表 4 - 4 身份線索對情感信任作用之線性混合模型摘要 57
表 4 - 5 評論效價對情感信任作用之線性混合模型摘要 59
表 4 - 6 經驗線索對認知信任作用之線性混合模型摘要 60
表 4 - 7 評論可信度之線性混合模型摘要 61
表 4 - 8 身份線索與評論效價交互作用之線性混合模型摘要 64
表 4 - 9 研究假設驗證結果一覽表 67

doi:10.6342/NTU202300441

第一章　緒論

第一節　研究背景與動機

由於醫療資訊的不透明與難以獲得，以及醫療專業知識的複雜性和難以理解，一般大眾在獲取與理解醫師資訊、選擇醫院或醫師的過程，往往會遭遇重重困難。醫病雙方知識的不對稱，經常造成民眾在進行醫療決策上的困難、挫折與不滿。

當民眾出現尋找新醫師的資訊需求時，人際資源管道一直是重要的資訊來源。選擇醫師時，親友、同事與鄰居的推薦與建議，也經常被當作醫師選擇決策的重要參考意見（李旻鴻，2012；謝慧欣等人，2000；Zhang et al., 2020），醫師的聲譽也有很大一部分建立在病患的口碑推薦之上（Billinghurst & Whitfield, 1993）。

隨著網路的發展與普及，人們逐漸轉向線上搜尋與獲取健康資訊，並在看診前事先搜尋醫師的相關資訊（Hay et al., 2008）。大約在 2000 年左右，開始有醫師評價網站（Physician Review Website, PRW）出現，隨著大眾獲取資訊的方式與習慣改變，醫師評價網站的能見度與使用率在二十年內迅速成長，逐漸成為民眾在搜尋與獲取醫師資訊時，在人際資源管道外，另一個重要的資訊來源與決策依據。

根據各國的調查發現，有越來越多民眾會參考醫師評價網站的資訊，依據線上評論的建議選擇特定的醫師，或避開特定的醫師（Emmert et al., 2013；Gao et al., 2012；Hanauer et al., 2014；López et al., 2012）。根據 Zhang 等人（2020）的調查發現，當人們的醫療需求涉及個人隱私時，人們也普遍不願意向親友尋求醫師資訊，而是傾向於透過線上評論尋找有關醫師的資訊。

然而，由於線上評論的匿名性，與醫療服務的特殊性。使得線上醫師評論的可參考價值，和民眾對線上醫師評價的接受和信賴程度，不若其他類型商品或服務之線上評論（Rothenfluh et al., 2016）。部分的使用者樂於使用和仰賴醫師評價網站獲取有關醫師的資訊，但也有部分使用者對評論的真實性與可信度有些顧慮而不願採納。

或許是因為醫師評價網站仍不若其他類型的線上評論廣為大眾所知，相對地，整體的使用率也較低，因而過去對醫師評價網站的研究，各國的研究者仍多以內容

doi:10.6342/NTU202300441

分析或問卷調查等方式探討醫師或醫院評論內容的結構特徵、使用者的特徵與使用概況（Chiu & Chang, 2015；Drevs & Hinz, 2014；Emmert et al., 2014；Gao et al., 2012；López et al., 2012；Terlutter et al., 2014），僅少數研究關注醫師評價網站的資訊呈現對使用者進行醫師選擇決策的影響。

由於醫師評價網站已逐漸成為大眾獲取醫師資訊的重要資訊來源與決策依據，且醫師評價網站的出現也被認為可望促進醫療資訊的透明性（transparency）和提升醫療服務品質（Emmert et al., 2013；Emmert et al., 2016）。但是醫師評價網站上內容的呈現，會對一般大眾進行醫師選擇的決策造成何種影響，目前仍未被充分探索。因此，本研究選擇以醫師評價網站作為研究主題，並以 Walther（1992）提出的社會訊息處理理論（social information processing theory）為基礎，探討於匿名的醫師評價網站使用情境，提供哪些社會線索能有助於提升使用者對評論的信任，並聚焦討論使用者如何從醫師評價網站上的評論者資訊形成對評論者的感知，而使用者對評論和評論者的信任又會如何影響使用者的醫師選擇決策。

doi:10.6342/NTU202300441

第二節　　研究目的與問題

根據 Walther（1992）提出的社會訊息處理理論，在線上環境的互動，因為缺乏面對面互動時可獲得的非語言線索（nonverbal cues）對互動對象進行推測，因此，人們傾向使用線上環境中其他可得的替代線索來對互動方進行推測和判斷。而這些在線上環境中被使用者用來作為判斷輔助依據的資訊線索，通常被稱為社會線索（social cues）。各式提供社會線索的機制與設計，已被眾多線上評論或其他科技中介傳播（Computer-mediated Communication, CMC）的研究證實，能提升使用者對互動對象的社會臨場感（Xu, 2014），或讓使用者對互動方的信任產生正向影響（Ma et al., 2017；Steinbrück et al., 2002；Xu, 2014）。

醫師評價網站的出現不僅可以促進醫療資訊的透明性，也有望提升醫療服務的品質，醫師評價網站的能見度也在近二十年內迅速地提升。不過，醫師評價網站的匿名評論設計，使部分使用者認為難以完全信任網站中的評論，也引發不少爭論，陷入應採取身份認證以提升各界信任，或維持匿名設計以保障病患隱私的兩難中。

站在維護病患隱私的立場，本研究主張應維持匿名設計，在獲取與公開評論者身份和維持匿名設計的兩難中，進一步理解在醫師評價網站的使用情境，提供哪些社會線索有助於使用者判斷和評估評論者的可信度，即成為一項值得探究的問題。

本研究以社會訊息處理理論（Walther, 1992）為基礎，並借鑑既有的研究發現，提出以下兩個研究問題，和相關的研究假設（將於第二章說明）與實驗設計（將於第三章說明），探討在必須維持一定匿名性的醫師評價網站使用情境中，不同類型的社會線索會如何影響使用者形成對評論者的感知，及其對使用者決策的影響。

研究問題一：在匿名的醫師評價網站使用情境中，不同類型的社會線索會如何影響使用者對評論者的感知？

研究問題二：在匿名的醫師評價網站使用情境中，使用者對於評論者和評論的信任，會如何影響使用者選擇醫師的意向？

doi:10.6342/NTU202300441

第三節　　研究範圍與限制

本研究意欲探討的研究問題為：在匿名設計的醫師評價網站，不同類型的社會線索會如何影響使用者對評論者的感知，進而影響其選擇醫師的決策。因線上評論的使用者包含的群體範圍較廣，在考量實驗設計與執行面向後，本研究選擇以年齡和使用經驗作為限縮條件，以年齡介於 21 至 30 歲之間，且過去三個月內有使用線上評論經驗的成年人作為研究對象，此一族群的特性為：過去普遍較少有醫療需求和使用醫療服務的經驗，但對於閱讀和利用一般線上評論的經驗較為豐富。由於不同年齡層、或使用線上評論頻率不同的使用者，對網頁內容呈現資訊的敏銳程度有別，故本研究之研究結果可能無法適用於其他具備不同特性的群體。

在醫師專業的選擇上，由於關於醫師評論與決策的相關研究指出，在選擇不同專業科別的醫師時，病患或其代理人會對醫師的特徵與屬性有不同的偏好，例如：在選擇婦產科醫生時，人們更在意性別、家長在選擇家庭醫生時，他們更在意醫師的溝通能力（Howell & Gardiner, 2002；Li & Hubner, 2019）。醫療風險的高低和需求本身，同樣也都會影響使用者的決策過程和依據（Han et al., 2019）。

囿於研究規模和人力限制，無法於本研究同時納入不同專業科別的醫師且考量多種醫療需求進行比較和檢視。基於看牙醫屬於一般大眾較為共通的經驗，大眾也對牙醫的醫療服務成效有較高的辨別能力，為了讓較少有使用醫療服務經驗的群體，在參與實驗時有較強的代入感，故選擇牙醫，並以突發的智齒痛而產生的醫療需求作為實驗情境。

此外，若依據傳播的媒體性質區分，電子口碑可分為純文字形式的線上評論、加上照片輔佐說明的複合式評論，及影片形式傳播的電子口碑。由於電子口碑傳播的形式多以文字形式表達和散布，且本研究以對醫師服務的評論為研究標的，故在本研究中討論的電子口碑與線上評論，均只聚焦於文字形式的線上評論，含有照片或影音形式的評論則不在本次研究的討論範圍。

doi:10.6342/NTU202300441

第二章　文獻探討

本研究的研究目的是為了理解在醫師評價網站的使用情境中，人們如何評估和判斷陌生資訊來源是否可信，以及在維持匿名設計的前提下，提供哪些社會線索可能有助於提升使用者對評論者和評論的信任，最終又會如何影響使用者的決策。為理解在此一背景下，有哪些可能的因素會影響人們評估資訊來源的過程，社會線索的提供會如何影響人們的感知與判斷。本章將於前二節依序簡介以電子口碑與醫師評價網站為題的相關研究概況與待解謎題，接著於第三節說明關於人們如何於線上環境中對互動對象進行評估的相關研究發現，並於第四節總結。

第一節　電子口碑

在傳統的口碑傳播（Word of Mouth, WOM）研究中，研究者普遍認為口碑傳播的有效是源於傳遞資訊的對象（source）與接收者（receiver）之間的關係，而雙方的社會關係愈緊密、或是兩者的相似性愈高，則口碑傳播的影響力也就愈高（Brown & Reingen, 1987）。隨著網際網路的普及與發展，傳統口碑轉移到線上環境傳播，被稱為電子口碑（electronic Word of Mouth, eWOM），根據 Hennig-Thurar 等人的定義（2004），電子口碑係指「消費者在網路上向不特定的多數人表達、分享其自身消費特定產品、服務的經驗和看法」。

電子口碑的傳播可以發生在社群媒體，如：Facebook、Instagram；或電子商務網站，如：Amazon、momo；或綜合型的評價網站，如：Yelp、Foursquare；或特定類型的評論網站，如：書評網站 goodreads、anobii，電影評論網站 IMDb、爛番茄，旅館評論網站 TripAdvisor、Airbnb 與醫師評價網站 HealthGrades、RateMD 等。隨著線上評論的普及與盛行，線上評論已逐漸成為當代消費者獲取商品資訊不可或缺的資訊來源管道與決策參考，對消費者潛在的購買意願與實際的購買行為皆具有相當的影響力（Chevalier & Mayzlin, 2006；Formann et al., 2008；Hu et al., 2008）。

不過，除了透過社群媒體或在具備社群機制的評論網站上所發表的電子口碑，大多數電子口碑的傳播路徑中，接受訊息的觀者（viewer）與分享資訊的評論者

doi:10.6342/NTU202300441

（reviewer）通常互不認識，也導致使用者對於陌生的資訊來源及其內容，抱持一定程度的懷疑，而需要借助其他資訊線索輔助判斷。因此，使用者要如何推測陌生的評論者和其撰寫的評論內容是不是可靠和值得信賴，即成為電子口碑研究中重要且有趣的研究議題。

以下將依序說明在線上評論的既有研究中，曾發現有哪些元素會影響人們判斷評論是否可信，又有哪些因素會影響人們評估線上評論可信度和是否採納評論意見的過程。

線上評論的使用者可依其行為區分為瀏覽評論的人（viewer）、和撰寫評論的人（reviewer）。目前普遍認為撰寫評論的消費者在實際購買或使用特定產品後，通常基於利他心理，而在網路上留下對特定商品的評論，希望自己的評論能幫助和自己有類似需求的人，或是避免他人和自己遭遇類似的負面經驗（Hennig-Thurar et al., 2004）。瀏覽評論的消費者則是基於避損原則，因而在購買特定商品前，上網尋求與購買目標產品相關的評論，用較低廉的成本獲取相關資訊，以降低決策風險（Malik & Hussain, 2018；Manes & Tchetchik, 2018）。

至於消費者為何會採納陌生評論背後的原因，相關研究的解釋為：和商家提供的產品資訊相比，由消費者撰寫的線上評論，被消費者認為更真實而值得信賴（Ballantine & Yeung, 2015）。消費者也因為相信評論者是基於利他心理撰寫評論，而願意相信其評論內容（Hennig-Thurar et al., 2004）。

隨著線上評論被研究證實與產品銷售具有密不可分的關係（Chevalier & Mayzlin, 2006；Formann et al., 2008；Hu et al., 2008），站在營運商的角度來看，如何辨別和篩選出真正有價值的評論，以優先呈現給使用者，也是重要的議題。因此，具一定規模的評論或電商網站也紛紛為其平台添加不同的功能，以輔助消費者過濾資訊。例如：Amazon 為評論添加了萃取的服務，讓消費者可以藉由從眾多評論萃取的關鍵字，迅速得知評論討論的面向。而 Amazon、TripAdvisor 與 Yelp 等平台則按評論者的評論數量、或經由統計其他平台使用者給予特定評論的評價集合（例如：認為該則評論有幫助的投票數量），給予部分評論者專家的標章，或透過平台運算對

doi:10.6342/NTU202300441

評論者進行排行。如 Yelp、Foursquare 等平台則建立和發展社群，讓使用者能有其他的社會線索以推測評論者的可信賴程度。

不過，不同於部分評論網站在協助消費者獲取資訊層面做出的努力。隨著線上評論逐漸成為當代消費者重要的資訊來源與決策依據，線上評論也逐漸成為商品。在餐廳評論與書籍評論的領域，均有研究指出在餐廳剛開幕或書籍剛上市的階段，業者會在短時間內發布大量不實評論，或有操縱評論的行為（Hlee et al., 2021；Hu et al., 2011）。

根據 Walther（1992）提出的社會訊息處理理論（social information processing theory），人們會在線上環境中，使用其他線索替代非語言線索對互動方進行推測和判斷。由於使用者瀏覽評論的目的為獲取資訊，輔助自身進行消費的決策，而線上評論又多是源於陌生的資訊來源，線上評論的相關實證研究也發現：使用者在觀看線上評論時，並不只單純閱讀評論內容，其注意力也會外溢至周遭的線索，並擷取環境中的線索，來推測評論者是否可信（Dai et al., 2018；Hu et al., 2008）。

然而，當環境中充斥越來越多的不實評論，讓使用者要藉由線索判斷評論是否值得相信更加困難，雖然可以透過 AI 技術偵測和辨別不實評論（Martinez-Torres & Toral, 2019；Mayzlin, Dover & Chevalier, 2014），使用者也意識到有一定比例的線上評論是受到業主操作的不實評論，包含對自身的吹捧、及對競爭對手的貶損或惡意攻擊（Hu et al., 2012），但近期由 Azimi 等人（2022）進行的實驗研究發現：使用者目前仍相對缺乏辨別評論真偽的能力。

藉由回顧線上評論相關的研究發現，本研究於此簡要地歸納影響使用者評估和判斷評論可信的元素可分為：與評論內容有關的線索，以及與評論者有關的線索。與評論內容有關的線索包含：評論的長度（Mudambi & Schuff, 2010）、評論的品質（Zhao et al., 2018）、評論的可讀性（Fang et al., 2016；Korfiatis et al., 2012）、及評論效價（Ba & Pavlou, 2002；Qiu et al., 2012）等。與評論者有關的線索則有：評論者的聲譽（過去評論被覺得有用的數量）（Ghose & Ipeirotis, 2011; Xu, 2014）、評論者註冊網站的時長（Banerjee et al., 2017）、社交能力（好友數）（Banerjee et al., 2017; Liu & Park, 2015）和評論者發布評論的頻率與新近程度（Ngo-Ye & Shina, 2014）

doi:10.6342/NTU202300441

等。此外，評論者是否在評論網站中附上個人照片，也會影響使用者感知評論者的社會臨場感（social presence），並進而影響使用者對評論者的信任（Xu, 2014）。

除了與評論本人或是評論者有關的線索，會影響使用者評估評論者或評論是否值得信賴以外，使用者自身、評價網站，及評論商品的類型，也會影響使用者評估和判斷評論的過程。例如：Tang（2016）的研究指出，若使用者對評論產品（奇幻小說）的涉入程度較高，則較不容易受到評論的影響。Park 與 Lee（2009）的研究則發現，評論網站的信譽高低，也會影響評論的說服力。更有一系列的研究借鑑 Nelson（1970, 1974）提出的商品類型框架，證實使用者在瀏覽與搜尋不同商品類型的情形下，會有不同的認知與行為（Lee & Shin, 2014；Park & Lee, 2009；Sen & Lerman, 2007；Sun et al., 2019）。

Nelson（1970, 1974）依據消費者在消費之前或之後可獲取產品的資訊和特性，將產品分為搜尋型商品（search goods）、體驗型商品（experience goods）以及信用型商品（credence goods）。依照 Nelson 定義的商品類型框架，搜尋型商品的產品資訊較為客觀，消費者可以較輕易地透過二手資訊得知產品的特徵，且得以藉此判斷該產品的品質和屬性，例如：電視、電鍋、電風扇。體驗型商品則指消費者難以透過二手資訊評估產品的好壞與價值，消費者唯有在實際使用、體驗過該產品或服務後，才能夠判斷產品品質的好壞或合適與否，例如：書籍、電影、旅館。若消費者購買或親身體驗特定產品或服務一段時間以後，還是難以判斷該產品或服務品質的優劣，則歸類為信用型商品，例如：醫療服務、汽車維修、顧問服務。

由於商品本身屬性的差異，線上評論的相關研究發現，使用者不僅在閱讀不同類型的產品評論時，會有不同的使用行為，使用者對於評論的接受程度與相關線索的解讀，也會有不同的反應。例如：Senecal 與 Nantel（2004）的研究發現，相較於購買搜尋型商品，在購買體驗型商品時，他人的推薦較能發揮作用。Park 與 Lee（2009）則發現：和搜尋型商品相比，負面評論對體驗型商品的殺傷力較大，網站信譽的效應也對體驗型商品評論的影響力較大。由於體驗型商品的經驗性質，也讓使用者較容易因自身對體驗型商品的涉入程度高低，對正面或負面的商品評論產生不同的歸因。

doi:10.6342/NTU202300441

根據 Nelson 對商品分類的定義與前述線上評論研究的相關發現，似乎可以想見使用者對信用型商品的線上評論可能會抱持更多懷疑，也會花更多時間蒐集信用型商品的資訊，以規避損失、降低決策的風險。有趣的是，雖然為孩子找醫生普遍被認為比找假期入住的旅館更重要，不過根據 Rothenfluh 等人的研究（2016），在醫師評價網站和旅館評論網站擁有相同介面設計的實驗中，受試者反而花了更多的時間瀏覽旅館評論，而不是瀏覽和比較醫師的評論。

由於醫師服務和其他商品評論屬性具有本質上的差異，而線上評論既有的研究也證實使用者會因為商品類型的不同，對線索有不一樣的認知、解讀與決策過程。因此，理解醫師評價網站有哪些特性，及大眾在搜尋醫師與進行醫師選擇決策時，會看重哪些面向，即成為理解使用者如何看待醫師評價網站和資訊呈現的過程中，極為重要的一環。

doi:10.6342/NTU202300441

第二節　　醫師評價網站

一、醫師評價網站使用與研究概況

根據近年的調查研究發現，醫師評價網站的使用已逐漸成為大眾獲取醫師資訊與決策的重要依據，各國的使用情況雖略有不同，但普遍呈現成長的趨勢（Gao et al., 2012；Kadry et al., 2011；López et al., 2012）。其中以美國、德國、英國和中國的使用和發展較為成熟，也有相對豐富的研究發現，其他國家則仍處於發展階段。在台灣，則有林家圻與邱銘心（2019）、邱銘心與張家翎（2015）先後對網路上的醫師資訊和醫師評價網站之特徵進行內容分析研究。

依據 Hong 等人（2019）對醫師評價網站研究的系統性文獻回顧整理，在英國、德國和中國這三個國家中，大眾主流使用的醫師評價網站相當一致：在英國，多數的醫生和醫院都在 National Health System Choice 上被評價，在德國，最常被使用的專業醫師評價網站為 Jameda，在中國則是好醫生網站。在美國，大眾對醫師的評論則分散在一般類型的消費者評價網站（如：Yelp、Google Maps）和專業的醫師評價網站上（如：Vitals、HealthGrades、RateMD）。在台灣，除了商業周刊建置的良醫網具有一定的使用量（邱銘心、張家翎，2015），多數民眾仍仰賴 Google Maps 或 PTT、Dcard 等社群平台獲取醫師資訊與他人對醫師的評價。

根據各國調查研究顯示，整體來說，醫師被評價的比例不是太高，即使在醫師評價網站發展相對成熟的國家，仍有超過半數的醫師未在醫師評價網站上獲得任何民眾評論。在德國，大約只有 37% 的醫師曾經在醫師評價網站 Jameda 上獲得評價，且有將近一半的醫師只獲得一次評價，僅有不到 2%的醫師在醫師評價網站獲得超過 10 次以上的評價（Emmert & Meier, 2013）。在美國，即使在擁有最多醫師資訊的 HealthGrades，也僅有不到三成的醫師曾經獲得評價，且只有三位醫師在調查列表的所有醫師評價網站（HealthGrades、Wellness、RateMD）獲得超過五次的評價（Mostaghimi et al., 2010）。不過，根據對美國醫師評價網站的調查，雖然醫師整體被評價的比例不高，但醫師獲得評論的數量在五年內有超過 12%的成長率（Gao et al., 2012），顯示大眾對醫師評價網站的認識和需求正迅速提升。

doi:10.6342/NTU202300441

此外，隸屬不同專業科別的醫師被評價的數量也有差異。根據調查，德國醫師評價網站上獲得評價比例最高的醫師科別依序為：骨科（59.2%）、皮膚科（58.9%）和婦產科醫師（56.9%），而放射科（10.4%）、麻醉科（7.9%）和實驗室專家（2.1%），或許是和病患的接觸時間與機會較少，他們獲得評價的比例明顯較低。（Emmert & Meier, 2013）。在美國，則是以婦產科醫師、外科醫師和家庭醫師獲得評價的比例較高（Gao et al., 2012）。

雖然醫師評價網站仍不若其他商業評論型網站普遍和被廣為使用，但逐年增加的使用人次與評價數量已獲得不少研究者關注。除了醫師獲得評價的比例與數量在各國略有差異，多數研究的主要發現相當一致：醫師評價網站上的醫師評價多數都是正面的評價（Emmert et al., 2014；Kadry et al., 2011；López et al., 2012），且大眾對醫師的評價多呈現兩極化的現象，多數的醫師被大眾評價為最高評級，而少部分的醫師被評為最低評級（Gao et al., 2012；López et al., 2012）。

二、醫師評論的特徵對決策的影響

若從醫師評價網站整體的特徵來看，與過去線上評論的研究發現一致，被評價對象獲得的評論數量會影響人們對被評價對象的看法。當一個醫師收到的評論數量越多，會讓患者形成對醫師越正面的評價（Grabner-Kräuter & Waiguny, 2015）。

不過，不同於過去線上評論研究中，既有研究對正面評論或負面評論何者較具影響力未有一致的意見與發現（Ba & Pavlou, 2002；Gershoff et al., 2003；Pavlou & Dimoka, 2006）。目前醫師評價網站的相關研究皆指出，和正面評論相比，負面評論對使用者來說有較大的影響力：當某醫師的負面評論比例較高時，使用者較不願意選擇該醫師（Han et al., 2019；Li et al., 2015）。不僅醫師在醫師評價網站上收到負面評論的比例，和使用者願意選擇醫師的意願呈負相關，且評論出現的先後也會造成影響。在其他條件不變的情形下，當負面評論出現在正面評論之前，也會明顯降低使用者選擇該位醫師的意願（Li et al., 2015）。

若從個別評論特徵的角度來看，與過去線上評論的研究發現相似（Fang et al., 2016；Korfiatis et al., 2012；Zhao et al., 2018），醫師評價網站中的評論內容特徵也會

doi:10.6342/NTU202300441

影響使用者的決策，除了評論內容的敘事風格會影響使用者的選擇，評論內容側重的面向也會影響使用者對醫師的態度和選擇（Grabner-Kräuter & Waiguny, 2015；Li & Hubner, 2019）。

Grabner-Kräuter 與 Waiguny（2015）的實驗研究發現：當評論數量較少時，和情感型的評論相比，事實型的評論會讓觀看者對醫師產生比較正面的評價和態度。不過當特定醫師在網站上獲得一定的評論數量時，情感型評論產生的影響力較大。Li 與 Hubner（2019）的實驗研究則指出：在衡量醫師不同面向的能力時，不論選擇何種類型的醫師，人們皆傾向選擇專業技術能力評分較高的醫師，但若和選擇家庭醫師相比，在選擇專科醫生時，人們較容易在人際溝通能力上作出妥協。

若從使用者需求的面向來看，不論使用者的醫療需求風險高低，醫師評價網站上的評論都會對使用者的決策產生影響，而風險高低則對使用者採納評論的意願有關鍵影響。若鄰居推薦的醫師擁有正面的線上評價時，醫療風險高的患者會更願意選擇該位醫師，而醫療風險低的患者則更有可能選擇沒有線上評論及線上評論偏向負面評價的醫師（Han et al., 2019）。

三、醫師評價網站中的爭議與待解謎題

雖然有越來越多的人們仰賴醫師評價網站的內容獲取醫師資訊，醫師評價網站上的內容也被證實會影響使用者對醫師的看法與態度，並影響使用者進行醫師選擇的決策（Hanauer et al., 2014）。不過，一般民眾是否具備對醫師專業與醫療結果判斷的能力也引發不少質疑。不論是一般大眾或專家，大家皆普遍認為病患缺乏對醫師的專業和醫療服務成效做出正確判斷和評價的能力（Holliday et al., 2017）。根據 Rothenfluh 等人（2016）的訪談發現，部分受訪者也因為認為大眾沒有能力對醫師的治療結果進行判斷，因此無法全然相信醫師評價網站上的評論。

綜合對醫師評價網站的既有研究發現，我們可以得知使用者對醫師評價網站的信任程度有相當差異，部分使用者樂於使用，且仰賴醫師評價網站的資訊進行醫師選擇決策，但也有部分使用者表示無法完全信任和依靠線上評論做出決定。然而，使用者究竟是從何角度判斷何為「好醫師」，又或是使用者是仰賴哪些資訊進行醫療

doi:10.6342/NTU202300441

相關的決策，目前相關領域的研究發現仍未對此提出充足和合理的解釋，病患決策的過程仍被視為是黑盒子（Schlesinger et al., 2014 ）。因此，要如何提供更多有助於使用者做決策的資訊，似也較難著力。

為了保護評論者（病患）的隱私，也避免評論影響醫病關係，醫師評價網站多採用匿名發表評論的機制，但也因此引起不少對醫師評價網站的討論和反對聲浪。反對者認為匿名的評論機制可能導致大量對醫師的抱怨，這樣的負面評論對使用者理解醫師並無任何幫助。匿名的評論機制設計也難以排除因商業競爭或是離職員工狹怨報復產生的攻擊性評論，缺乏身份認證的設計可能導致醫師評價網站充斥不實評論，而使用者也無從分辨評論的真實與否。此外，反對者也擔憂線上評論會損害醫生的信譽和權威（Jain, 2010；McCartney, 2009）。

不過，多數的研究者仍主張應保持開放，甚至應有積極作為促進醫師評價網站的發展，從支持者的角度來看，醫師評價網站不僅可以為患者提供更多消費者角度的資訊，同時也有望藉此提升醫療服務的透明度（transparency），及改善整體的醫療服務品質（Emmert et al., 2016）。基於對醫療資訊透明化的追求與對病患賦權（empowerment）的理念，各國政府紛紛對此採取了不同的政策，例如：建立官方的醫師評價網站，或鼓勵民眾上網對醫師進行評價等。

Trehan 與 Daluiski（2016）曾對當前的醫師評價網站提出建議改善方向，包含：在公佈特定醫師的評價前，應至少收集五至十則評價，避免單一或少量負面評價對醫師名譽造成過大損害，且此舉也可提升該醫師評價網站的可信度。此外，Trehan 與 Daluiski（2016）也認為網站的營運方應該設計身份認證機制，確保給予醫師評價的使用者確實是該位醫師的患者，以降低評論造假的可能，並在特定情形下，提供醫師消除異常評論的機制。

然而，Trehan 與 Daluiski （2016）的觀點仍較偏向以醫師為中心或管理者角度的思維思考和規劃網站設計與營運，且未將病患對隱私的顧慮納入考量。依據 McLennan 等人（2018）的研究調查報告，病患不願意在線上對醫師發表評論的主要原因，即為對隱私的考量。然而，要如何在保有病患隱私的前提下，營造出讓民眾

doi:10.6342/NTU202300441

願意分享自身經驗與看法的使用氛圍，且可同時提升民眾對醫師評價網站的信任，仍有待更多研究進行深入探討。

四、小結

雖然在早期的調查中，大眾對醫師評價網站的認識不若其他商品評論網站（Hanauer et al., 2014），不過，醫師評價網站的使用率已在近二十年內迅速成長，且逐漸成為大眾在找醫師時，獲取醫師資訊的重要資訊來源管道與決策依據。

而醫師評價網站的匿名評論設計，則引發不少爭議。反對者認為匿名評論不僅可能會損害醫師名譽、破壞醫病關係。在商業競爭的環境，也會誘使同業發布不實評論。在無法辨別評論是源於真實經驗，或是惡意造假、造謠的情形下，醫師評價網站只會帶來負面影響。若站在使用者角度，醫師評價網站的匿名評論機制，則讓使用者因難以辨識評論是否源於真實的評論者，而有無法完全信賴的情形。然而，若要網站在註冊階段即收集使用者的個資，則會衍生複雜的信任與資料使用問題，同時，網站是否能妥善保存和管理使用者個資，也有資安方面的疑慮。

doi:10.6342/NTU202300441

第三節　從線索到決策

藉由檢視電子口碑與醫師評價網站相關的研究發現，我們可以知道在電子口碑的傳播中，與評論或評論者有關的資訊呈現，是使用者在獲取特定商品資訊的過程中，於線上環境中可及的線索，也是使用者判斷評論或評論者是否可信的依據。而和使用者自身、評論平台或評論的商品特性有關的因素，則會影響使用者對線索的感知與解讀，進而影響使用者最後的購買意願或行為。

透過回顧醫師評價網站的相關研究，研究者歸納醫師評價網站目前的使用概況存在以下幾個問題：使用者對評論是否源於真實經驗的懷疑、普遍對醫師評價網站內容的擔憂（病人是否有能力評估醫師診斷的成效），及個別醫師的評論數量和可供判斷資訊過少，而讓使用者難以信任評論者，或難以評估是否應該採納評論意見。因此，本研究認為在醫師評價網站的使用情境，判斷評論的帳號是不是真實的使用者，為使用者觀看評論和決定是否要採納評論者意見重要的前提。另一方面，基於醫療服務屬於信用型商品，判斷評論者是不是有能力評估醫師的服務，則是另一個關鍵。

為了保障病患的隱私，醫師評價網站均為匿名設計。不過，本研究認為匿名性並不是一個全有或全無的概念，而是一個連續性的概念，即使同樣處於匿名環境，仍會因互動對象身份揭露的程度差異反映人們感知匿名性的強弱。由於既有研究多顯示匿名性會引發人們對互動對象真實性的懷疑，也會進而影響人們判斷其資訊的可信任程度。因此，本研究選擇以身份線索作為研究變項，討論在維持一定匿名性的情形下，身份線索的豐富程度與其反應的匿名性程度高低，對使用者的感知有何影響。

承前所述，在醫師評價網站中，醫師獲得的評價多呈現兩極化，而在線上評論的研究中，評論效價也因其資訊作用力的方向不同，普遍被視為是左右使用者決策的關鍵因素。且在醫師評價網站的相關研究也發現，評論效價於整體評論中的呈現或位置皆會對使用者決策造成顯著影響，故本研究也將評論效價納入研究變項。

而醫療服務雖然具有強烈的信用型商品屬性，既有研究也指出人們普遍對一般大眾是否有能力判斷和評估醫師診斷的成果抱持懷疑，因而無法盡信醫師評價網站

doi:10.6342/NTU202300441

中的評論內容。不過，根據探討來源可信度與線上評論的相關研究發現，資訊來源若被標示為專家或有經驗者，多半會讓使用者對該資訊來源有更高的信任（Craciun & Moore, 2019；Liu & Park, 2015）。因此，本研究選擇納入經驗線索作為研究變項，檢驗在醫師評價網站的使用情境中，經驗線索的呈現會如何影響使用者對評論者的感知。

由於身份線索和經驗線索對使用者判斷評論者是否值得信任的面向有別，為了區分身份線索與經驗線索分別會影響信任的何種層面，因此，本研究採用 McAllister（1995）所定義和區分的認知信任和情感信任來代表使用者對評論者的信任，根據 McAllister 的定義，認知信任意指：「對互動方能力和可靠程度的信心」（grounded in individuals belief about peer reliability and dependability），而情感信任則是「源於人際交流間的關懷和關心」（grounded in reciprocated interpersonal care and concern）。

除了藉由區分信任為不同面向的信任，以得知不同類型的社會線索對不同面向信任的影響是否有所不同外，本研究也對不同的面向如何影響評論可信度，並進而影響使用者最終的選擇決策感興趣。基於前二節文獻回顧的相關發現和上述原因，本研究選擇「身份線索」、「經驗線索」與「評論效價」作為研究的自變項，並探討這些變項對使用者的感知與決策有何影響。以下說明本研究的假設發展。

一、從線索到感知

（一）身份線索和社會臨場感

匿名形式的互動在線上環境中相當普遍，使用者經常只會以自行命名的暱稱、ID 和他人進行互動。Rains 與 Scott（2007）指出缺乏身份線索的實體，會引發人們對其提供資訊的可信任程度的懷疑。人們如何在線上環境中形成對陌生人的信任，是許多對線上活動進行研究的研究者們共同的興趣與謎題。

身份線索的提供與揭露，會增進使用者對互動方的信任，已在電子商務、線上論壇、共享經濟等不同的線上互動情境中獲得廣泛的支持和證實（Fu et al., 2022；Steinbrück et al., 2002） 例如：在 Airbnb 的個人資訊頁提供較詳細資訊的屋主，相對

doi:10.6342/NTU202300441

更容易受到消費者青睞和信任（Ma et al., 2017）。大多數的線上平台也鼓勵使用者為自己建立帳戶和提供個人資訊檔案（profile）。

在線上評論的環境中，使用者為了規避損失、降低決策的風險，會竭盡所能地擷取可用的資訊線索，來推測評論者是否值得信任（Dai et al., 2018；Hu et al., 2008）。Forman 等人（2008）利用 Amazon 的評論資料進行分析，即發現身份線索（地理位置）的提供對提升評論可信度與線上購物的銷售有明顯關聯。Banerjee 等人（2017）和 Kusumasondjaja 等人（2012）的研究也有類似發現：提供關於評論者的資訊，可以減少人們對資訊來源的懷疑與不確定性，並增進使用者對評論的信任與評論的影響力。

不過，身份線索的揭露與否對信任的影響，雖然已在其他線上互動情境研究中獲得廣泛的支持，但在線上評論的相關研究中，並未得到一致的研究發現。同樣在線上評論的情境下，Siering 等人（2018）的研究提出不同的證據，在該研究中身份線索的提供反而對感知評論的幫助（helpfulness）有負面影響，與此同時，身份線索的提供與否對評論可信度並無任何影響。

此外，在線上評論的研究中， Hassanein 與 Head（2007）也發現社會臨場感在線上評論的環境中扮演重要的角色，對消費者感知評論有用、購物選擇都有正面的影響。社會臨場感（social presence）的概念最早由 Short 等人（1976）提出，意指：「媒介能夠讓雙方在心理上感受到彼此存在的程度」。經常被用來比較在面對面和以電腦為中介的溝通環境下（computer-mediated communication, CMC），因媒介可傳遞的訊息量多寡，對於互動雙方感知彼此存在程度的影響。而使用者感知社會臨場感的程度，也對使用者對互動方的信任有一定的影響。

隨著研究的發展，不同研究者對社會臨場感提出不同的定義和解釋，如：「在虛擬環境中與他人在一起的感覺」（Biocca et al., 2003）、「虛擬的社會實體，以感官或非感官的方式被體驗和認知為真實的社會實體」（Lee, 2004）。綜合不同學者的觀點和研究，可得知社會臨場感的核心為：個體如何有效地透過電腦中介環境的互動，將對方視為真實的社會實體。根據 Oh 等人（2018）的系統性文獻回顧整理，過去的

doi:10.6342/NTU202300441

研究發現：互動性（interactivity）、顯示裝置（display）、音訊品質（audio quality）、身份線索（identity cue）等因素皆會影響使用者對社會臨場感的感知。

而近期亦有研究者以身份線索的有無（真名且附有照片 vs. 匿名且沒有照片）為實驗因子，以線上論壇為背景對社會臨場感進行探討，研究發現身份線索的提供會增強人們對社會臨場感的感知（Feng et al., 2016）。其他研究則發現，匿名性會減少人們對社會臨場感的感知（Schumann et al., 2017；Zhao et al., 2018）。綜合上述研究發現，我們可以合理推測身份揭露程度的多寡，會影響互動方對社會臨場感的感知程度。

承上所述，本研究認為匿名性並不是一個全有或全無的概念，而是一個連續性的概念，因此，即使同樣是匿名的情形下，仍有身份揭露程度多寡之別。而過去對匿名性與身份線索揭露的相關研究中，多以身份線索提供的有無進行討論。不過，在維持一定匿名性的情形下，身份線索揭露程度的多寡和其反映的匿名性高低是否能與前述研究發現有一致的結果，能讓使用者因感知身份揭露程度較高，而對互動對象的信任造成正向影響，值得進一步進行研究與討論。

因此，本研究將借鑑於前述研究的發現，發展實驗設計，並於實驗中檢驗，在維持匿名的情形下，身份線索揭露程度的多寡和其反映的匿名性高低，是否會影響使用者對評論者的信任。由於多數研究皆證實身份線索的提供能提升使用者對互動對象的信任，故本研究假設：**即使在維持一定匿名性的使用情境，「提供身份線索的豐富程度仍會影響使用者對評論者的情感信任，而社會臨場感則會中介身份線索與情感信任間的關係」。**

（二）評論效價

評論效價（review valence）為線上評論研究中不可忽視的存在，由於大多數的評論皆持有特定立場，對評論的目標有正面或負面的評價，因此，評論效價於線上評論中的作用，往往會對使用者的決策有關鍵的影響，同時，也極少有中性評論的存在。在醫師評價網站的情境下更是如此，根據過去對醫師評價網站的調查發現，醫師獲得評價的分佈也多呈現極端分佈，絕大多數醫師獲得的評價都是極端正面的

doi:10.6342/NTU202300441

評價，少數醫師會獲得極端負面的評價（Emmert et al., 2014；Gao et al., 2012；Kadry et al., 2011）。

與其他類型的商品評論相似，在使用者評估線上醫師評論的情境中，評論效價對於使用者評估評論與採納其意見與否，佔據了相當重要的角色。在醫師評價網站的使用情境中，研究發現負面評論比正面評論有更大的影響力（Han et al., 2019；Grabner-Kräuter & Waiguny, 2015）。

近期的一項實驗研究發現，就連負面評論出現的先後和位置，也會對使用者的決策造成影響：當負面評論出現在正面評論之前，即會明顯降低使用者選擇該醫師的意願（Li et al., 2015），由此可見，當評論呈現方式出現些微的變化，即可能影響使用者對判斷對象的感知。

綜合相關研究發現，本研究認為評論者給予醫師正面或負面的評價，可能也會從根本改變使用者感知和接收線索的情境。基於使用者會擷取線索形成對互動對象的印象，**研究者推測評論者提供正面或負面的評價，也會直接或間接影響使用者對評論者的印象**。使用者可能會因為評論者撰寫正面或負面的評論，而對評論者產生好感或排斥，影響使用者對評論者的觀感，但不會影響使用者推測評論者的能力，故於此提出研究假設三：「**評論效價會影響使用者對評論者的情感信任**」。

（三）經驗線索

在過去對評論者可信度的研究中，評論者的聲譽（reputation）和經驗能力（experience）可說是最常被討論的兩個變項。過去已有一些線上評論研究以不同的方式表示評論者的經驗能力，如：評論者過去評論的總數（Liu & Park, 2015）、註冊該網站的時間長度（Banerjee et al., 2017）、網站給予的排行或專家標章（Craciun & Moore, 2019），並證實這些由系統彙整關於評論者的資訊，都會讓使用者對於評論者的信任、判斷評論內容的品質、認為評論有用或其購買意願造成正向影響（Shan, 2016；Xu, 2014）。

基於醫療服務具有明顯的信用型商品屬性，大眾也多不認為一般人有判斷醫師診斷成果的能力，因此，於醫師評價的情境中，使用者是否會因為評論者的經驗值

doi:10.6342/NTU202300441

高低而產生不同的感知或解讀仍屬未知。不過，由於評論者是否擁有對評論對象多過於自身或他人的理解，仍是使用者在評估資訊來源是否可信時相對具有說服力的線索。且過去的線上評論研究發現，若標示資訊來源為專家或有經驗者，多能影響使用者對來源可信度的判斷（Banerjee et al., 2017；Liu & Park, 2015），因此，本研究仍選擇經驗線索作為變項，希望經驗線索的提供能有助於提升使用者對醫師評論的信任。

至於在操作化的面向，本研究認為在體驗型商品的情境（如：旅遊評價或餐廳評論），之所以可以將評論者過去整體評論的數量等同於評論者的經驗能力，是因為評論者評論的對象是相似的，因此可以將兩者約略劃上等號。但是若置於評估醫療服務的情境，評論者過去的評論總數似乎就不再適合作為評論者經驗的表示。如果將一般感冒看病和看婦產科、牙醫、身心科的經驗都視為相似的經驗，並將評論者過去的評論數量加總概括，代表評論者的經驗能力，可能會有些失準。

本研究認為在醫師評價網站的使用情境下，平台應該提供評論者過去於該主題留下的評論歷史，才能更精確地表示評論者的經驗能力，並成為人們評估陌生資訊來源是否可信和衡量評論是否對選擇決策有幫助的社會線索。因此，本研究將使用「評論者於特定主題的評論歷史」來表示評論者的經驗能力。

基於多數線上評論的研究發現均顯示，標示評論者對評論產品知識有豐富經驗的線索會讓使用者更信任該評論，或覺得該評論更有幫助。為了得知經驗線索是否於信用型商品中具有相似作用，和經驗線索是否有助於提升使用者對線上醫師評論的信任，故提出研究假設四：「**評論者資訊中的經驗線索，會影響使用者對評論者的認知信任**」。

二、從信任到決策

雖然線上評論中的信任對於影響消費者的購買意願與消費決策扮演相當重要的角色，不過，也正如前述文獻分析整理提及，在線上評論的研究中發現有相當多與評論或評論者有關的線索，和從使用者、平台到商品類型等多重因素會影響信任的形成。就閱讀的文獻所知，線上評論中的信任曾被以多種形式討論，包含：對評論

doi:10.6342/NTU202300441

本身、對評論者、對平台的介面和平台營運商等，然而，使用者對不同對象之間的信任彼此會如何相互影響，仍處於相對未知的狀態。

由於在傳統口碑傳播中，傳遞訊息的角色被視為是影響傳播的關鍵，而在電子口碑的研究中，資訊來源也被認為是影響信任形成與建立的決定性因素。因此，本研究將試圖於此探討對評論者的信任與評論可信度之間的關係。

根據信任轉移理論（trust transfer theory），信任可以在不同的個體之間轉移（Stewart, 2003），例如從線上轉移到線下、或線下轉移到線上（Lin et al., 2011）。就研究者所知，過去對信任轉移的研究多關注同一對象在不同管道的信任轉移，而在線上評論的研究中，使用者對評論者的信任和使用者對評論的信任兩者之間的關係仍屬未知，故在此提出研究假設五，討論使用者對評論者的信任，是否會對使用者感知評論內容的可信度造成影響：「**使用者對評論者的認知信任和情感信任，會影響使用者對評論可信度的感知**」。

根據線上評論既有研究的發現，使用者對評論的信賴程度多半會對其購買意願造成正向的影響，不過，過往的實證研究多數以搜尋型商品與體驗型商品為情境，鮮有研究對信用型商品進行討論，加上信用型商品的特性為使用者無法準確地判斷商品或服務的品質。因此，使用者感知評論的可信度是否仍會對使用者的選擇意向造成影響，仍舊值得更多研究驗證。

延續過去線上評論研究對信任的討論，由於多數的研究發現使用者對於評論的信任會影響使用者對推測對象的感受和決策。因此，我們假定在信用型商品的使用情境，使用者對評論的信任也會影響其最終的選擇決策，並於此提出研究假設六：「評論可信度會影響使用者的選擇意向」，以透過此研究確立其間的關係。

doi:10.6342/NTU202300441

第四節　　小結

依據本研究欲探討的研究問題一：在匿名的醫師評價網站使用情境，不同類型的社會線索會如何影響使用者對評論者的感知？綜合前述文獻回顧的結果，立基於社會訊息處理理論和社會臨場感理論，本研究提出以下四則研究假設，並於此繪製研究假設之模型如圖 2-1 ：

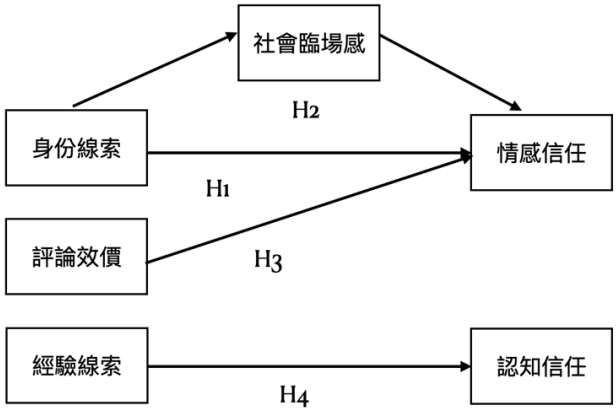
H1: 評論者資訊中身份線索的豐富程度，會影響使用者對評論者的情感信任

H2: 使用者對評論者感知的社會臨場感，會中介身份線索與情感信任間的關係

H3: 評論效價會影響使用者對評論者的情感信任

H4: 評論者資訊中的經驗線索，會影響使用者對評論者的認知信任

圖 2 - 1 研究假設之模型一



本研究提出的第二個研究問題是：在匿名的醫師評價網站使用情境，使用者對評論者的信任，會如何影響使用者感知評論的可信度？又會如何影響使用者選擇醫師的意向？

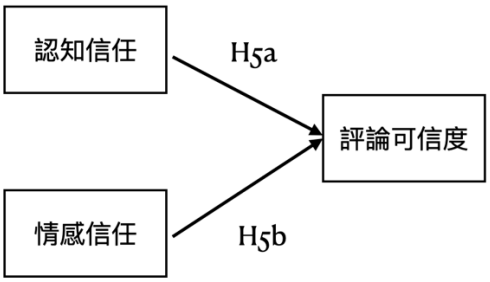
根據信任轉移理論（trust transfer theory），信任可以在不同的個體之間轉移（Stewart, 2003）。過去對信任轉移的研究多關注同一對象在不同管道的信任轉移，例如從線上轉移到線下、線下轉移到線上（Lin et al., 2011）。就研究者所知，使用者對評論者的信任是不是能轉移到對評論的信任仍相對未知，故在此提出研究假設五，討論使用者對評論者的信任，是否會影響使用者感知評論內容的可信度。研究假設之模型如圖 2-2 所示：

doi:10.6342/NTU202300441

H5a: 使用者對評論者的認知信任，會影響使用者對評論可信度的感知

H5b: 使用者對評論者的情感信任，會影響使用者對評論可信度的感知

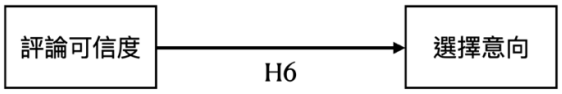
圖 2 - 2 研究假設之模型二



延續過去線上評論研究中的發現，使用者對評論的信賴程度多會對其購買意願造成正向的影響，由於過往的實證研究多以搜尋型商品與體驗型商品為使用情境，鮮有研究者對於信用型商品進行討論，加上信用型商品的特性為使用者無法準確地判斷商品或服務的品質。因此，使用者感知評論可信的程度是不是仍會對使用者的選擇意向造成影響，仍值得更多研究進行驗證，故於此提出最後一則研究假設，以透過此研究確立其間的關係：

H6: 評論可信度會影響使用者的選擇意向

圖 2 - 3 研究假設之模型三



doi:10.6342/NTU202300441

doi:10.6342/NTU202300441

第三章 研究方法

本章共分為六個小節，第一節將說明研究方法與情境的選擇，第二節將說明研究對象的選擇與招募，第三節將說明研究工具的設計與選擇考量，第四節將說明變項操縱的設計呈現與前測結果，第五節將說明實驗分組的原則與實驗流程的操作細節，最後於第六節說明研究資料的蒐集方式與資料分析的方法。

第一節 研究設計

由於過去的相關研究發現，病患的醫療決策經常心口不一，病患主張重視的決策依據，和其實際的決策行為經常大相徑庭（Schlesinger et al., 2014），使用者從環境中擷取線索、形成感知亦為相對隱性的過程，若透過問卷或訪談方式直接詢問使用者的選擇依據，恐無法真確反映真實的情況。因此本研究選擇以實驗法進行研究，採 2x2x2 的組內實驗設計（within subject factorial design），實驗操縱變項分別為評論者的身份線索：即評論者的頭像與 ID，和評論者的經驗線索：即評論者於特定主題的評論歷史，以及評論效價：即正負評。

此外，過去的相關研究也指出，不論是專家或一般大眾，均普遍認為一般人相對缺乏對醫師專業和醫療服務結果評估的能力（Holliday et al., 2017；Rothenfluh & Schulz, 2017）。基於找牙醫被認為是中高涉入程度的醫療服務需求，且相對其他科別的醫師（如：內科、骨科），一般大眾較能從中累積經驗，也相對有能力衡量與判斷牙醫的專業與醫療服務結果（Grabner-Kräuter & Waiguny, 2015）。因此，本研究參考 Grabner-Kräuter 與 Waiguny 的研究設計（2015），以尋找和選擇牙醫作為實驗情境，並將原先的任務描述改寫為適合此研究的說明。實驗使用的情境與任務說明如下：

「你在上個週末剛搬到一個新的城市（TaiTai）生活，昨天晚上，因為突然的智齒痛而讓你難以入睡，你想找一間附近的牙醫看診。但是你對於當地的牙醫一無所知，也還不認識熟悉當地的朋友。因此，在這個情況下，你決定上網搜尋牙醫的資訊。接下來，請你在醫師評價網站的首頁（電腦畫面顯示的頁面），輸入城市名稱『TaiTai』，實際搜尋這個城市的醫生資訊」。

doi:10.6342/NTU202300441

第二節 研究對象

根據 Lim與Van Der Heide 的研究發現（2015），使用者過去的使用經驗和對平台的熟悉程度，皆會影響使用者對線上評論及系統產生線索的信任程度，為避免受試者間經驗的變異對實驗結果造成影響，本研究以「近三個月內有閱讀線上評論的經驗」作為篩選條件。並於招募受試者階段，以以下兩個問題於招募問卷中調查受試者在過去購買產品或選擇服務前，查看一般線上評論與查看醫師評論的頻率：「在購買產品或選擇服務前，我會上網搜尋評論，參考別人對特定產品或服務的評價」（1=從不，10=總是）、「每當我要找新醫生時，我都會到網路上尋找醫生的評價」（1=從不，10=總是）。並依據在招募問卷的調查結果，作為實驗分組的依據。

依據醫師評價網站相關的調查指出，年輕人為醫師評價網站的主要使用族群（Terlutter et al., 2014），研究設計的實驗情境亦是緣於智齒痛而產生的就醫需求，故本研究也將醫學臨床經驗所述的智齒平均萌發年齡作為參考（Renton & Wilson, 2016），選擇以21至30歲的群體作為研究對象。

基於既有研究的發現指出使用者過去使用特定評論網站的經驗、對推測對象的理解和涉入程度、使用網路的熟悉程度，皆會影響使用者接收、感知和解讀線上評論網站中的相關資訊線索。為了避免受試者間的差異影響實驗結果，本研究以「近三個月內有閱讀線上評論的經驗」和「21 至 30 歲」作為篩選條件，選擇 21 至 30 歲且近期有閱讀線上評論經驗的群體當作研究對象。

研究對象的招募則以此一年齡區間較常使用的社群媒體：Instagram、Facebook、Dcard、PTT、噗浪公告實驗的招募說明，主要招募管道為鄰近實驗地點（國立台灣大學圖書資訊學系系館）的各大學 Facebook 交流版，包含台大、台師大、台科大等，輔以研究者自身和人際網絡的社群媒體平台與通訊軟體轉發招募資訊。完整的招募說明與招募問卷可參閱附錄一。

doi:10.6342/NTU202300441

第三節 研究工具

一、實驗網站

在實驗網站的設計與製作，由於過去的研究發現，使用者對平台的熟悉程度，會影響使用者理解網站的資訊（Lim & Van Der Heide, 2015）。同時，使用者對特定的評價網站或平台營運商的信任，也會影響使用者看待該網站評論的可信度（Flanagin & Metzger, 2007）。因此，為了避免受試者過去對特定評論網站的使用經驗影響實驗結果，本研究將獨立製作一模擬的醫師評價網站原型作為實驗用網站。

首先，研究者先列出各國的醫師評價網站[1]，以及在台灣使用率較高、涵蓋使用族群較廣的評論網站，如美國的醫師評價網站 HealthGrades、RateMD、德國的醫師評價網站 Jameda，及綜合型評論網站 Yelp 和 Google Maps，並觀察彙整不同網站中共通的功能，最後選擇對應實驗需求打造基本的功能：搜尋、呈現搜尋結果、閱讀評論、切換畫面等，添加不會影響實驗進行和結果的註冊、登入功能按鈕（未實際實作功能），和滑鼠游標停留在按鈕位置會改變按鈕顏色的效果[2]，以提升實驗網站的擬真程度（詳如圖3-1、3-2）。

在介面設計上，則以網站常見的排版設計為原則，在所有的網頁中，左上角均放置代表該網站的標識（logo）與網站名稱，右上角放置註冊與登入的功能。在閱讀醫師評論的頁面設計中也加入麵包屑（breadcrumbs）導覽列（詳如圖3-3），以提升實驗網站的擬真程度。由於許多提供醫藥健康相關資訊或服務的網站均採用深藍色背景，依據色彩心理學，藍色也代表沉穩與專業，因此實驗網站也選擇相近的深藍配色，以貼近大眾對醫療網站的印象，也避免任選不恰當或不符合大眾印象的配色讓受試者認為實驗網站不專業或有突兀感，而降低對網站本身的信任。

[1]如美國的醫師評價網站：HealthGrades(https://www.healthgrades.com)、RateMD(https://www.ratemds.com)、德國的醫師評價網站：Jameda(https://www.jameda.de)。

[2] Hover effect

doi:10.6342/NTU202300441

圖 3 - 1 實驗網站頁面功能示意圖 1

圖 3 - 2 實驗網站頁面功能示意圖 2

註：hover effect

圖 3 - 3 實驗網站頁面功能示意圖 3

註：提升網站擬真程度的麵包屑導覽列

doi:10.6342/NTU202300441

實驗網站的資訊呈現和排列方式，同樣參考其他評論網站的呈現，由於台灣人習慣由左至右、由上而下的閱讀，因此，整體資訊配置的位置與實驗素材的陳列也按照這樣的原則排序與呈現。在資訊呈現的選擇上，則排除既有研究中表明會影響使用者選擇醫師決策的資訊，例如：醫生的特徵與背景，包含：性別、年資、醫生所處的醫院層級、醫生畢業的學校等（Peuchaud, 2020）。在排除會影響決策的相關資訊後，實驗網站上的醫師資訊呈現，僅顯示醫師的姓氏和示意用的電話、地址。

在網頁的操作與程式實作方面，為了讓受試者在填答對評論者感知的問題時，可以對照完整的評論資訊（包含身份線索、經驗線索與評論內容）畫面，在操作的設計上，研究者透過 CSS（Cascading Style Sheets, CSS）中的 sticky 設計讓評論資訊畫面的內容可以固定在畫面上方，受試者可以同時觀看欲評估的評論者資訊，一邊獨立滾動問卷的捲軸填答問題（如圖 3-4）。也透過 HTML 中 disabled 的設計搭配 JavaScript 監控受試者的操作，以控制受試者的閱讀順序，當受試者閱讀完單一評論且完成相應的問卷後，才可閱讀下一則評論（如圖 3-5、圖 3-6）；並讓受試者在填答選擇醫師的意向之前，讓受試者回到該醫師評論頁面的上方，讓受試者再重新瀏覽該醫師的所有評論後再回答（如圖 3-7）。

此外，考量實際執行實驗時，會依照受試者可參與的時間安排實驗進度，而非依照實驗分組順序進行，因此，在程式實作時，也將切換不同組別評論頁面的功能獨立設計，在實驗執行時即可在短時間迅速變更實驗網站的呈現頁面。

圖 3 - 4 實驗網站控制操作示意 1

doi:10.6342/NTU202300441

圖 3 - 5 實驗網站控制操作示意 2

圖 3 - 6 實驗網站控制操作示意 3

圖 3 - 7 實驗網站控制操作示意 4

doi:10.6342/NTU202300441

二、測量量表

本研究使用和測量的變項包含：社會臨場感（social presence）、情感信任（affective trust）、認知信任（cognitive trust），評論可信度（review credibility），及選擇牙醫的意向（selection intention），針對各變項測量使用的量表均參考前人研究發展的量表再加以調整，所有變項均以李克特七點量表進行測量（1=非常不同意，7=非常同意），各個變項使用的量表題項內容與來源整理如表 3-5，附錄三則可參閱量表的原文及翻譯對照。

其中，由於社會臨場感的概念為多重構面組成，不同領域或專注於不同對象的研究者也提出不同版本的量表，基於語意和情境考量，本研究選擇同樣於線上評論情境研究使用的量表（Gafen & Straub, 2004），該量表原是用於測量使用者對網站的感知，而本研究測量感知的對象為評論者，故將量表翻譯後，將題項中的感知對象均由網站改為評論人，例如：「當我閱讀評論時，可以感覺到評論人的個性」。

承前所述，為了理解不同類型的線索對不同面向信任的影響，本研究選擇源於人際交流互動的情感信任，和源於能力與可靠程度的認知信任，來測量對評論者的信任。對於評論可信度的測量，則基於受試者整體填答題數的考量，為避免受試者填答的題數過多，於此僅選取原始量表中較具代表性的問項「我覺得這則評論是可信的」進行測量。

此外，情感信任、認知信任和評論可信度的量表選擇，同樣選擇原先是應用於線上評論研究情境使用的量表。最後，關於對使用者選擇醫師意向的測量，本研究選擇同樣以線上醫師評論為背景進行醫師選擇決策研究的量表（Han et al., 2019）。

表 3 - 1 研究使用量表題項與來源一覽表

變項	題項	測量	來源
社會臨場感	1 當我閱讀評論時，可以感覺和評論人有人際接觸 2 當我閱讀評論時，可以感覺到評論人的個性 3 當我閱讀評論時，可以感覺到評論人的友善 4 當我閱讀評論時，可以感覺到評論人的溫度	1=非常不同意，7=非常同意	Gafen & Straub, 2004

doi:10.6342/NTU202300441

變項	題項	測量	來源
	5 當我閱讀評論時，可以感覺到評論人人性化的特質		
情感信任	1 如果我問一個關於醫生看診的問題，我覺得這位評論者會用心地回答 2 我覺得我可以很自在地和這位評論者交談 3 我覺得這位評論者很親切 4 如果我表達我對於某位醫生的擔憂，我認為這位評論者會給予有建設性的回應 5 我認為評論者會開誠佈公地表達對這位醫生的看法	1=非常不同意，7=非常同意	Xu, 2014
認知信任	1 我會對這位評論者的建議有所保留* 2 我可以依靠這位評論者給予的建議 3 基於網頁上呈現的資訊，我不會懷疑這位評論者的判斷 4 基於網頁上呈現的資訊，我會完全採納這位評論者的建議	1=非常不同意，7=非常同意	Xu, 2014
評論可信度	1 我覺得這則評論是可信的	1=非常不同意，7=非常同意	Chang & Wu, 2014
選擇意向	1 我會選擇這位醫生的可能性（1=非常低，7=非常高） 2 我認為這個醫生是一個不錯的選擇 3 我會將這位醫生列入考量	1=非常不同意，7=非常同意	Han et al, 2019

doi:10.6342/NTU202300441

第四節 前測

為了確認實驗素材的使用符合實驗設計的目的，因此在正式實驗前，研究者先將擬於實驗中使用的變項及變項可能的操縱呈現，預先以線上問卷的方式進行衡量與篩選，以確保變項的呈現確實存在差異。

前測問卷共有三部分，第一部分測量身份線索的呈現、第二部分測量經驗線索的呈現、第三部分測量評論內容及評論效價的呈現。此外，研究者另於問卷設計中穿插兩題注意力檢測的問題：「這一題請選選項 2」與「這一題請選選項 6」，以確認線上問卷填答的有效性，若有任一題未正確回答者，則該問卷視為無效問卷。

前測問卷於 2022 年 9 月進行資料的蒐集，問卷填答條件同實驗的研究對象篩選條件，經過兩週的時間，共收集了 57 份樣本，其中有 15 份問卷為無效問卷， 42 份問卷為有效問卷。以下說明前測操作的細節與素材篩選的結果。

一、身份線索

由於多數探討身份線索的研究，多半使用正面、半身且明顯可辨識個人身份的照片當作刺激物（Ert et al., 2016；Lee & Shin, 2014；Xu, 2014），然而，在醫師評價網站的使用情境，為了保障病患隱私，不適合使用可明顯辨識身份的全身照或半身照作為頭像。身份線索的呈現，要如何維持一定的匿名程度，又具有一定的可辨識程度，以提升社會臨場感和使用者對個別評論者的信任，實為一大難題，就回顧的文獻中也無相似的案例可供參考。因此，研究者參考過去以身份揭露與社會臨場感有關的研究（Ma et al., 2017；Mudambi & Schuff, 2010；Toma, 2010），選取既有研究中共通出現但又不是可以明確辨認身份的線索：個人興趣。在無法明確辨識使用者身份的前提下，挑選能呈現使用者興趣的照片，作為身份線索豐富的刺激物，搭配其他類型的圖示做比較。

在頭像方面，首先選取明確可辨識的照片當作比較基準，如 A03，再挑選八張僅呈現使用者剪影、背影或身體局部的照片作為實驗素材候選，如 A05 至 A12，而 A08 至 A12 可能被觀者推測照片主人的興趣為：慢跑、瑜伽、攝影、潛水及登山。

doi:10.6342/NTU202300441

另也挑選繪圖方式的人像作為比較，如 A04，前測使用的頭像素材詳見表 3-1。在 ID 方面，則以五種不同的英數字組合在前測中進行比較，詳見表 3-2。

關於身份線索呈現的衡量，以「我覺得這個帳號……」（1=匿名的程度高，7=可辨識身份的程度高）的問題進行測量（Rains & Scott, 2022），以可辨識身份程度的高和低進行篩選，決定實驗使用的素材。

分析前測問卷的結果顯示：除了作為比較基礎的全身正面照片 A03，和在略有遮掩的正面近照 A13 外，呈現使用者興趣的照片（A12、A11、A09、A08）被認為可辨識身份的程度較高，一般系統預設頭像的照片（A01）被認為可辨識身份的程度最低；ID 的呈現則以姓氏搭配四位數字的組合（A15）可辨識身份的程度較高，而單純以數字組合的 ID 呈現（A17）可辨識身份的程度最低。為了確認選為實驗素材的頭像和 ID 組合在身份線索的呈現上具有顯著差異，於此也將平均可辨識身份程度較高的前四個頭像，與可辨識身份程度最低的頭像，兩兩進行 t-test 分析，ID 的呈現也進行同樣的比較分析，分析結果顯示：預計作為實驗素材的頭像和 ID 的呈現確實在統計上具有顯著差異，詳見表 3-3。

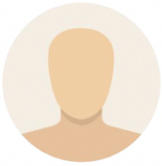
表 3 - 2 身份線索前測頭像素材與結果摘要表

編號	頭像	平均	備註
A03		5.76	作為比較基礎
A13		4.74	
A12		3.83	選為實驗素材

doi:10.6342/NTU202300441

編號	頭像	平均	備註
A11		3.69	選為實驗素材
A09		3.36	選為實驗素材
A08		3.33	選為實驗素材
A07		3.31	
A05		3.29	
A06		2.98	
A10		2.83	

doi:10.6342/NTU202300441

編號	頭像	平均	備註
A04		2.79	
A02		1.93	
A01		1.79	選為實驗素材

註：為便於閱讀，頭像素材逕依可辨識身份程度的平均降冪排序。在前測問卷中並非依此順序呈現。

表 3 - 3 身份線索前測 ID 素材與結果摘要表

編號	ID	平均	備註
A15	Chang1203	2.57	選為實驗素材
A14	Qwert	2.21	
A16	Emily	2.12	
A18	coriander hater	2.05	
A17	83472654	1.74	選為實驗素材

註：為便於閱讀，ID 素材依據平均降冪排序。在前測問卷中並非依此順序呈現。

表 3 - 4 身份線索呈現素材之獨立樣本 T 檢定結果摘要表

素材編號	*M*	*SD*	*t*	*p*	*Cohen's d*
A12	3.83	1.32	7.26	<.001	1.29
A01	1.79	1.26			

doi:10.6342/NTU202300441

素材編號	*M*	*SD*	*t*	*p*	*Cohen's d*
A11	3.69	1.52	6.25	<.001	1.40
A01	1.79	1.26			
A09	3.36	1.39	5.42	<.001	1.33
A01	1.79	1.26			
A08	3.33	1.43	5.27	<.001	1.35
A01	1.79	1.26			
A15	2.57	1.27	3.45	<.001	1.11
A17	1.74	0.91			

二、經驗線索

如前所述，本研究選擇以「評論者在特定主題的評論歷史」代表評論者經驗，並以比例的高低表現，表示經驗能力的線索將以長條圖的方式呈現，設定為經驗值高的呈現如圖 3-8、經驗值低的呈現如圖 3-9。在前測問卷中，將分別呈現顯示經驗能力高、低的經驗線索，透過語義差異的七點量表進行測量，藉此衡量經驗線索的呈現是否合適，確認觀者能據此感知、判斷附上不同經驗線索呈現的評論者其經驗有別。測量的問題包含：「我覺得這位評論者：是專家-----不是專家」、「我覺得這位評論者對看牙醫：沒什麼經驗-----很有經驗」、「我覺得這位評論者對看牙醫：一無所知-----非常了解」、「我覺得這位評論者…對牙醫發表意見：夠格-----不夠格」、「我覺得這位評論者…評估牙醫的服務：有能力-----沒有能力」（Ohanian, 1990）。分析前測問卷的結果顯示，兩種經驗線索的呈現，對使用者感知評論者的專業與經驗能力，在統計上確實有顯著差異：和反映評論者經驗值低的線索呈現相比（$M = 3.71$, $SD = 0.97$），受試者對於附有反映評論者經驗值高的線索的評論，認為該評論者的專業與經驗能力明顯較高（$M = 5.21$, $SD = 1.18$），t（82）$= 6.362$, $p < .001$。

doi:10.6342/NTU202300441

圖 3 - 8 經驗線索-經驗值高的呈現

圖 3 - 9 經驗線索-經驗值低的呈現

三、評論效價與評論內容

如同在文獻探討章節提及，與評論本身有關的線索，包含：評論內容的品質、長度、情緒強度，皆會影響使用者對評論的感知與評價，使用者對評論內容的感知也會對評論者的信任造成影響（Mudambi & Schuff, 2010；Schindler & Bickart, 2012）。由於研究的主軸為探討不同類型的社會線索如何影響使用者對評論者的感知與信任，為了避免評論的內容及其變異對實驗結果造成影響，正式實驗使用的評論內容素材，也事先透過前測篩選。

此外，根據社會訊息處理理論（Walther, 1992）和過去的研究發現（Lim & Van Der Heide, 2015），當使用者處於線索相對缺乏、對整體信任程度較低的情境，使用者較會參考多元的社會線索，對評估對象進行衡量。在評論內容相對充足可信時，使用者可能較不會根據其他線索衡量互動對象的可信賴程度。因此，在此研究中，

doi:10.6342/NTU202300441

評論內容將使用較短的文字，並使評論字數約略相等，以增加實驗參與者對於身份線索與經驗線索的依賴。

用於實驗的評論內容素材從一線上評論的資料集[3]裡隨機挑選，資料集內共有 770 則評論，平均每則評論的字數約為 44 字，故研究者從字數長度為 39 字至 49 字之間的評論中（滿分為五星、最低為一星），隨機挑選五星的正面評論和一星的負面評論各十則。再透過前測問卷測量，以確保使用者對實驗使用的評論內容素材感知評論可信的程度是接近的、但對感知評論的效價有明顯差異。前測使用的評論內容素材與結果詳見表 3-4。

在前測問卷中，測量評論可信度的問題包含：「我認為這則評論是事實」、「我認為這則評論是準確的」、「我認為這則評論是可靠的」、「我認為這則評論是可信的」、「我認為這則評論值得信賴」，以李克特七點量表進行測量（1=非常不同意，7=非常同意）（Chang & Wu, 2014）。對於正負效價，則以「我認為這則評論對醫生的評價」（1=非常負面，7=非常正面）進行測量。

表 3 - 5 評論內容與評論效價前測素材與結果

編號	評論內容（字數）	評論可信度平均	感知評級平均
C08	環境相當舒服有隔離開，不會像一般牙科診所在等待區直接看到診療的過程，醫師也相當仔細的處理（44）	5.37	5.26
C06	非常棒的牙醫診所，醫生會詳細跟你說情況及後遺症之類等等不會馬虎，助理人員也非常用心（41）	5.29	5.95
C03	第一次來做洗牙，護士接待服務親切，醫生操作專業，詢問也詳細說明，很舒服的就醫經驗（40）	5.06	5.98

[3] 評論資料集的資料來源為 Google Maps 中牙醫診所近兩年的評論。

doi:10.6342/NTU202300441

編號	評論內容（字數）	評論可信度平均	感知評級平均
C07	醫生很細心且客觀、牙助親切、診所隔間讓人覺得有隱私感、收費公道，很愉快的看診經驗（40）	4.95	5.55
C09	我真的非常害怕看牙醫，但非常感謝醫生跟護士都非常的細心跟充滿耐心。讓我能像正常人一樣認真的看完牙齒（49）	4.91	5.74
C05	這裡的服務人員很親切，醫師專業且表達過程語氣相當溫柔，讓很怕看牙醫的我安心很多（39）	4.85	5.64
C10	**醫生仔細，接待流程成熟，助手勤勞，氣氛和內裝都很舒服！令人看牙時不會感到特別緊張（40）**	4.82	5.43
C04	**醫師很專業也很細心，護士全程也都很溫和，讓從小就怕看牙醫的我感到很放鬆，大推～～～（41）**	4.67	5.71
C02	**醫師看診態度溫柔、櫃檯親切漂亮。很棒的看牙體驗！自從來看過後，就都來這間了。推推～（41）**	4.59	5.88
C01	**診所環境優美設備精良，醫護服務態度溫暖有禮，是一個舒適舒心的看診體驗！很讚大推（39）**	4.47	5.71
C11	**洗牙時表示很痛，結果醫師開始自暴自棄，一直說：我技術不好啦，不舒服的話下次找別家（40）**	4.26	1.88
C12	**沒有詳細解說情況就要我們拔牙，一點專業度都沒有，態度還很差、一點同理心都沒有！（39）**	4.15	1.67
C20	**我問今天能先幫我補讓牙齒舒服一點嗎？醫生回說那如果掉了不甘我的事。那口氣聽了很不舒服，不會再來了（48）**	4.14	2.00

doi:10.6342/NTU202300441

編號	評論內容（字數）	評論可信度平均	感知評級平均
C13	**我相信很多醫生都可以做得更好，而且不用等這麼久。非常後悔在這邊做拔牙，完全不推薦！（41）**	4.00	2.14
C17	一般人聽到拔牙都會怕 想評估原因 問他一句他回一句一點都沒有同理心~ 不建議大家來給他看診（42）	4.00	2.62
C16	很不開心 有點懷疑醫師的醫德 回答問題都愛理不理的只會跟我說看你啊 給的答案也不一定（39）	3.92	2.26
C15	這家牙醫的態度真的非常不推，單單看了 X 光片交談幾句 接著冒出一句我要下班了，治不治療看你（43）	3.84	1.90
C14	醫師看完後跟我說約下一次看診再治療？有沒有同理心？牙齒疼痛還可以約下次再治療嗎？（40）	3.75	2.31
C18	醫生一直問我要不要下面的去給大醫院拔，聽到真的很火，這輩子再也不會來這家，態度真的爛（42）	3.63	2.43
C19	醫生竟然看了一眼就說這無法治療，然後也沒要幫我洗牙的那種態度，真的有夠令人生氣（39）	3.61	2.07

註：標粗體表示選為實驗素材。為便於閱讀，評論內容皆以評論可信度的平均降冪排序。編號 C01 - C10 為正評、C11 - C20 為負評。

根據前測問卷的結果，整體來說，正面評價的評論平均可信度較高、負面評價的評論可信度相對較低。為了降低正面與負面評論之間評論可信度的差異，擬選取正面評論中可信度最低的四則評論，及負面評論中可信度最高的四則評論作為實驗素材。首先，先將評論依正負評分組，以檢驗正面評論和負面評論二組的評論效價呈現是否在感知評級存在差異，進行 ANOVA 檢定的結果顯示：參與者對評論之間的感知評級有顯著差異，$F（1, 334）= 1263.378, p < .001$；同時，參與者對評論之間的感知評論可信度也有差異，$F（1, 334）= 12.765, p < .001$。

doi:10.6342/NTU202300441

接著分別對正面評論與負面評論的素材進行單因子變異數分析，以確認參與者對正評與負評二組組內素材之間評論可信度與感知評級的差異程度，分析結果顯示參與者對正面評論組內的四則評論其感知評論可信度無顯著差異：F（3, 164）= .674，p =.569；對感知正負效價也無顯著差異：F（3, 164）= 1.601，p = .191。而負面評論素材的比較分析結果顯示，參與者對負面評論組內的四則評論素材其感知評論可信度和感知正負效價也均無顯著差異：F（3, 164）= .227，p = .878；F（3, 164）= 1.828，p = .144。由於前測挑選的評論素材在組內的評論效價與評論可信度均無顯著差異，且在正、負評二組間的感知評論效價有顯著差異，故確定將此八則評論選為實驗素材。

透過前測篩選，我們確定了「身份線索」、「經驗線索」與「評論效價」的變項操縱呈現，並組合如圖 3–10、圖 3–11 所示，完整的實驗素材呈現可見附錄二。

圖 3 - 10 變項操縱範例 1

註：身份線索呈現的身份揭露多、經驗線索透露經驗值高、正評

圖 3 - 11 變項操縱範例 2

註：身份線索呈現的身份揭露少、經驗線索透露經驗值低、負評

doi:10.6342/NTU202300441

第五節 實驗流程

一、實驗分組

承上所述，本研究採用 2 x 2 x 2 的組內實驗設計，因此，每位受試者皆會看到 8 則由不同評論者撰寫的評論和社會線索的呈現（詳如附錄二）。實驗的分組區分為 A、B 兩組，受試者會被隨機指派到 A、B 兩組，所有受試者皆會看到 2 位醫師的各 4 則評論，合計 8 則評論。為了避免實驗刺激出現的順序效應（order effect），或是正負評出現的位置先後影響實驗結果，實驗的分組將採拉丁方格設計（Latin square design），以平衡正評與負評出現先後順序所造成的影響。實際的實驗分組情形詳如表 3-6 所示。在收集受試者填答招募問卷的資料後，也會依據性別與過去使用評論的經驗程度，平均分配在不同組別。

表 3 - 6 實驗分組

分組	醫生	變項操縱 身份線索	變項操縱 經驗線索	變項操縱 評論效價
Group A1	Doctor 1	多	高	正評
		多	低	正評
		少	高	負評
		少	低	負評
Group A1	Doctor 2	少	高	正評
		少	低	正評
		多	高	負評
		多	低	負評
Group A2	Doctor 1	多	高	負評
		多	低	負評
		少	高	正評
		少	低	正評
Group A2	Doctor 2	少	高	負評

doi:10.6342/NTU202300441

分組	醫生	變項操縱 身份線索	變項操縱 經驗線索	變項操縱 評論效價
		少	低	負評
		多	高	正評
		多	低	正評
Group A3	Doctor 1	少	高	正評
		少	低	正評
		多	高	負評
		多	低	負評
Group A3	Doctor 2	多	高	正評
		多	低	正評
		少	高	負評
		少	低	負評
Group A4	Doctor 1	少	高	負評
		少	低	負評
		多	高	正評
		多	低	正評
Group A4	Doctor 2	多	高	負評
		多	低	負評
		少	高	正評
		少	低	正評
Group B1	Doctor 1	多	高	正評
		少	高	正評
		多	低	負評
		少	低	負評
Group B1	Doctor 2	多	低	正評

doi:10.6342/NTU202300441

分組	醫生	變項操縱 身份線索	變項操縱 經驗線索	變項操縱 評論效價
		少	低	正評
		多	高	負評
		少	高	負評
Group B2	Doctor 1	多	低	負評
		少	低	負評
		多	高	正評
		少	高	正評
Group B2	Doctor 2	多	高	負評
		少	高	負評
		多	低	正評
		少	低	正評
Group B3	Doctor 1	多	低	正評
		少	低	正評
		多	高	負評
		少	高	負評
Group B3	Doctor 2	多	高	正評
		少	高	正評
		多	低	負評
		少	低	負評
Group B4	Doctor 1	多	高	負評
		少	高	負評
		多	低	正評
		少	低	正評
Group B4	Doctor 2	多	低	負評

doi:10.6342/NTU202300441

分組	醫生	變項操縱 身份線索	變項操縱 經驗線索	變項操縱 評論效價
		少	低	負評
		多	高	正評
		少	高	正評

二、實驗流程

完成實驗分組後，即邀請符合條件的受試者進行實驗，實驗的流程如圖 3-12 的步驟所示。每位受試者皆會閱讀八則評論，搭配實驗設計的三種變項呈現組合，並依據評論頁面提供的資訊，回答對評論者的感知，及選擇醫生的意願。最後，也會對受試者進行簡短的訪談，以理解受試者對不同變項操縱呈現的看法，和變項操縱呈現對他們瀏覽評論的相關影響，以及對評論者形成印象背後的原因。以下依步驟詳細說明。

圖 3 - 12 實驗進行流程

在正式實驗開始前，會先和受試者再次確認符合實驗參與條件，接著口頭說明研究流程，並請其簽署研究參與者知情同意書（詳見附錄四）。為避免受試者對研究主題和目的的臆測影響實驗的進行與實驗結果，本研究參考其他研究的做法（Feng et al., 2016）：請受試者於實驗前抽籤，並告知受試者，實驗會依照抽籤的結果決定每位受試者要進行的任務組別，分配他們所閱讀的資訊（實際上在抽籤前已經事先

doi:10.6342/NTU202300441

決定好分組，受試者抽到的籤是經過設計的）。當受試者抽出一號及五號籤，代表要閱讀第一和第五位醫生的資訊和評論。

接著正式進入實驗內容，受試者會先閱讀文字想像置身於實驗設計的情境，並按照閱讀的任務說明，到實驗用的模擬醫師評價網站首頁（如圖 3-13），輸入指定的城市名稱，在實驗網站上搜尋該城市的醫師資訊。實驗網站上會依據搜尋的指令，呈現受試者的搜尋結果：該城市的醫生列表，而醫師列表上會列出八位醫生的資訊（如圖 3-14）。

根據抽籤的結果，受試者會先點擊進入第一位醫生的評論頁面（如圖 3-15），並依據實驗任務的說明，依序閱讀評論頁面中的所有評論。如前所述，為了即時捕捉受試者在閱讀評論後對於評論和評論者形成的印象，受試者在每讀完一則評論後，就會立即請受試者填答問卷，測量受試者對個別評論者與評論的感知，包含：社會臨場感、情感信任、認知信任與感知評論的可信度。受試者在提交相應的問卷後，才會呈現下一則評論的資訊（如圖 3-16）。

在個別醫生的評論頁面，受試者會重複「瀏覽評論資訊」和「填答相應問卷」的步驟，直到受試者瀏覽完四則評論、也完成對四位評論者的測量。接下來，網頁的設計會讓受試者自動回到該醫師評論頁的頂端，讓受試者再次瀏覽該醫生的所有評論，再請受試者依據此頁面提供的資訊，填答選擇該位醫生的可能性。

受試者依序完成瀏覽兩位醫生的評論頁面和相關問題的填答後，且確認系統已確實記錄實驗資料後，研究者會簡單地詢問受試者幾個問題，包含實驗刺激物是否對受試者造成影響，及其背後的原因可能為何，和受試者平時觀看線上評論的經驗與偏好等。最後，研究者會向受試者說明抽籤是因為實驗需求設計的環節，實際的分組與抽籤無關，並感謝他們的熱心參與，提供受試者參與實驗的報酬。

doi:10.6342/NTU202300441

圖 3 - 13 實驗網站之首頁

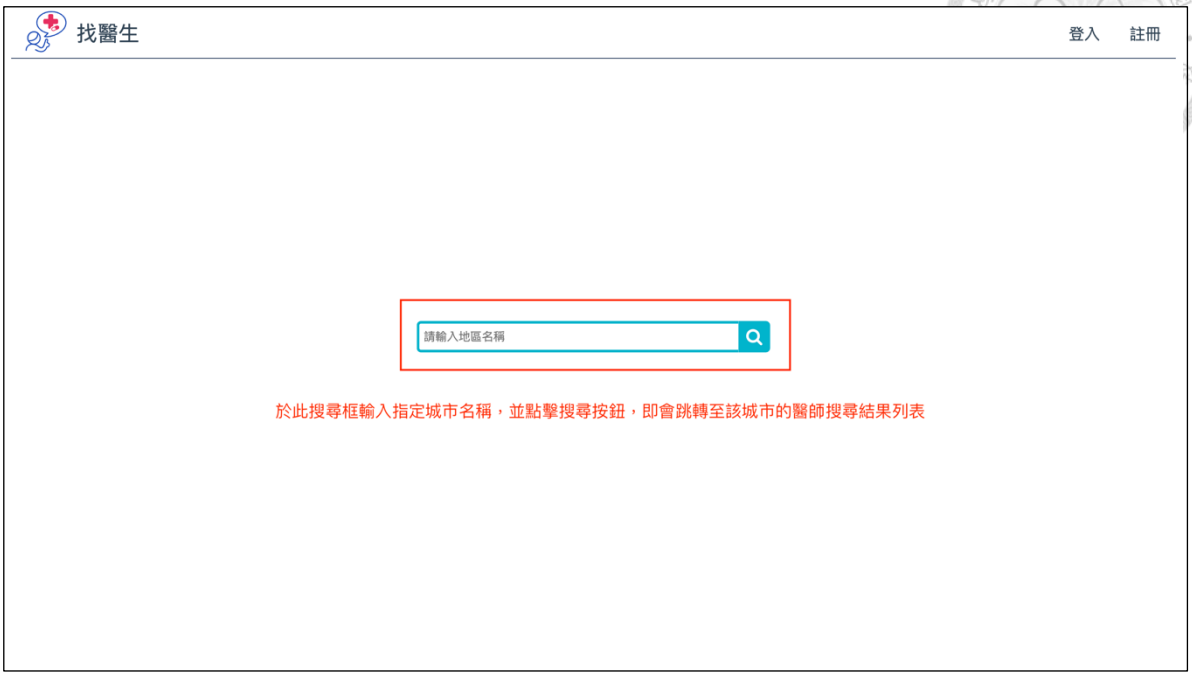


圖 3 - 14 實驗網站之搜尋結果頁面醫師列表

doi:10.6342/NTU202300441

圖 3 - 15 實驗網站之醫師評論頁面

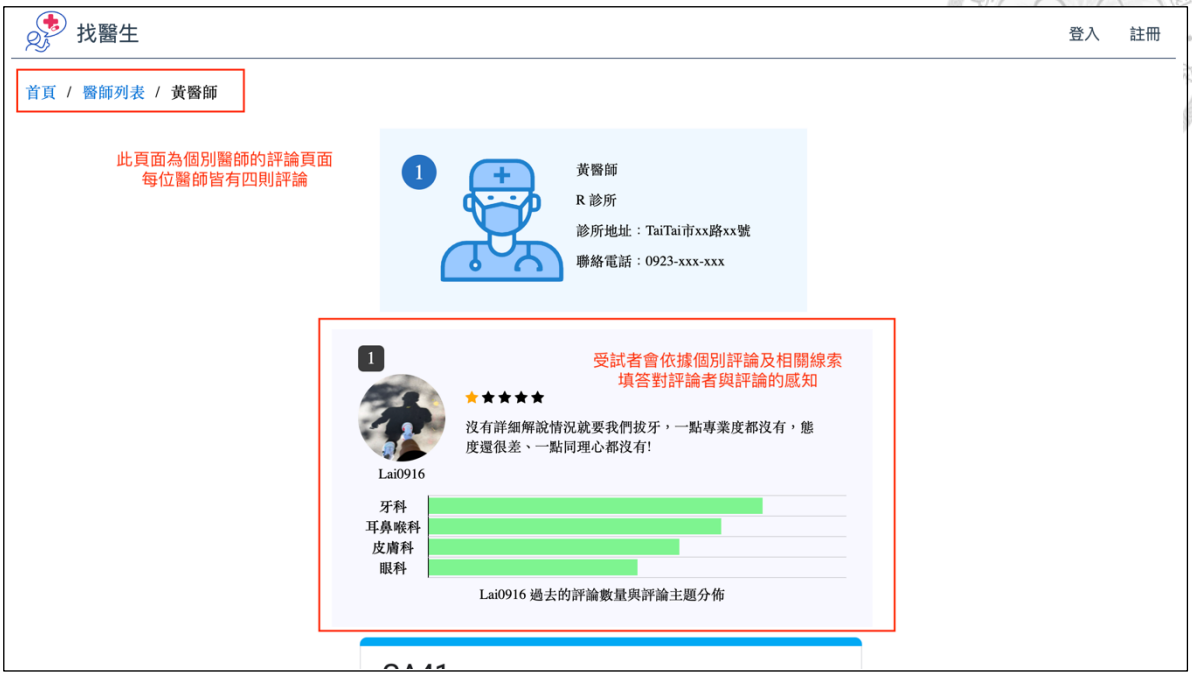


圖 3 - 16 實驗網站之操作流程範例

doi:10.6342/NTU202300441

第六節 資料蒐集與分析

實驗的實施使用研究者自行建置的模擬醫師評價網站原型進行，輔以內嵌 Google Forms 形式進行資料的蒐集，以即時關注、檢視受試者在實驗過程中是否遇到問題，同時也能在實驗結束後快速地確認資料是否完整、有沒有遺漏資料。

本研究於 2022 年 10 月 2 日至 10 月 25 日進行線上招募，合計有 109 人填寫實驗招募表單，研究者依序邀請符合招募條件的受試者參與，實際共 80 名受試者參與實驗，其中 32 名為生理男性、48 名為生理女性，年齡均介於 21 至 30 歲之間。實驗執行時間為 2022 年 10 月 6 日至 2022 年 10 月 29 日，實驗地點為國立台灣大學圖書資訊學系系館的第十二研究室，所有受試者均在相同座位進行實驗，實驗時長約 30 分鐘。

所有受試者完成實驗後，研究者將不同分組的資料彙整於 Excel 檔案，再根據實驗設計標記自變項、依據受試者的招募問卷標記性別、年齡、過去使用一般評論的經驗，以及過去使用醫師評論的經驗，完成所有資料的標記與統整後，匯入 SPSS 進行統計分析。

為了確保研究中使用量表的信度，首先對研究中使用的量表進行信度分析（reliability analysis），以確認各量表內部的一致性與可靠性。接著，對研究使用的所有變項進行相關分析（correlation analysis），以理解變項之間的關聯性。確認變項之間的關聯性後，再針對此研究關注的自變項「身份線索」、「經驗線索」、「評論效價」，與依變項「情感信任」、「認知信任」、「社會臨場感」、「評論可信度」與「選擇意向」進行迴歸分析，以理解自變項對依變項的影響及變項之間的交互作用。

doi:10.6342/NTU202300441

第四章 研究結果

第一節 樣本分析

本研究於 2022 年 10 月 2 日至 10 月 25 日進行線上招募，共有 109 人填寫實驗招募表單，研究者依據第三章說明的實驗設計與分組原則依序邀請受試者，實際有 80 名受試者參與實驗。其中 32 名為生理男性、48 名為生理女性。受試者年齡介於 21 至 30 歲之間，平均年齡為 23.92 歲，標準差為 2.675 歲。受試者的基本資料整理如表 4-1。

表 4 - 1 受試者基本資料

人口統計變項		人數	百分比	平均值	標準差
性別	生理男性	32	40%		
	生理女性	48	60%	-	-
	合計	80	100%		
年齡	21-25	60	75%		
	26-30	20	25%	23.92	2.675
	合計	80	100%		

為了理解受試者過去使用一般線上評論與醫師評論的經驗，在招募問卷中事先調查以下兩個問題，並邀請受試者依據自身經驗回答其使用的頻率（1=從不，10=總是）:「在購買產品或選擇服務前，我會上網搜尋評論，參考別人對特定產品或服務的評價」、「每當我要找新醫生時，我都會到網路上尋找醫生的評論」，受試者在過去使用一般線上評論的經驗平均值為 8.61（$M = 8.61, SD = 1.402$），而使用醫生評論的經驗平均值為 7.24（$M = 7.24, SD = 2.124$）。

doi:10.6342/NTU202300441

第二節 信度分析

研究測量的變項有「社會臨場感」、「情感信任」、「認知信任」、「評論可信度」與「選擇意向」，為了檢驗研究使用量表的信度，確保實驗使用的問卷題項是可靠的，除了「評論可信度」由於只有單一題項，其餘變項皆於此透過計算 Cronbach's α 係數進行判斷和檢驗，以剔除不適合的題項。

在「社會臨場感」的量表中，編號三的題項「當我閱讀評論時，可以感覺到評論人的友善」和量表中其他題項的一致性較低。在「情感信任」的量表中，編號五的題項「我認為評論者會開誠佈公地表達對這位醫生的看法」也與同量表中的其他題項一致性較低，在剔除此二題項後，社會臨場感與情感信任量表的 Cronbach's α 皆因此提高，故剔除量表中的此二題項。所有量表分析計算的結果詳見表 4-2。

經篩選與檢驗後，感知社會臨場感的 Cronbach's α 值為 .762（$M = 4.93$, $SD = 0.98$）、情感信任的 Cronbach's α 值為 .801（$M = 4.41$, $SD = 1.18$）、認知信任的 Cronbach's α 值為 .855（$M = 3.85$, $SD = 1.18$）、選擇意向的 Cronbach's α 值為 .930（$M = 3.38$, $SD = 1.31$），本研究使用的量表 Cronbach's α 值皆在 .75 以上，顯示研究使用的量表屬於高信度。

表 4 - 2 題項一覽表

變項	題項	刪除題項後的 Cronbach's α
社會臨場感	SP1 當我閱讀評論時，可以感覺和評論人有人際接觸	.614
	SP2 當我閱讀評論時，可以感覺到評論人的個性	.646
	SP3 當我閱讀評論時，可以感覺到評論人的友善	**.762**
	SP4 當我閱讀評論時，可以感覺到評論人的溫度	.537
	SP5 當我閱讀評論時，可以感覺到評論人人性化的特質	.610
情感信任	AT1 如果我問一個關於醫生看診的問題，我覺得這位評論者會用心地回答	.721
	AT2 我覺得我可以很自在地和這位評論者交談	.737

doi:10.6342/NTU202300441

變項	題項	刪除題項後的 Cronbach's α
	AT3 我覺得這位評論者很親切	.775
	AT4 如果我表達我對於某位醫生的擔憂，我認為這位評論者會給予有建設性的回應	.750
	AT5 我認為評論者會開誠佈公地表達對這位醫生的看法	**.801**
認知信任	CT1 我會對這位評論者的建議有所保留*	.843
	CT2 我可以依靠這位評論者給予的建議	.819
	CT3 基於網頁上呈現的資訊，我不會懷疑這位評論者的判斷	.803
	CT4 基於網頁上呈現的資訊，我會完全採納這位評論者的建議	.794
選擇意向	SI1 我會選擇這位醫生的可能性	.876
	SI2 我認為這個醫生是一個不錯的選擇	.901
	SI3 我會將這位醫生列入考量	.918

註：標*表示為反向題；粗體字表示為刪除題項

doi:10.6342/NTU202300441

第三節 相關分析

為了檢視變項之間的關係，本研究採用皮爾森相關分析進行檢驗，本研究的自變項為「身份線索」、「經驗線索」、「評論效價」，依變項為「社會臨場感」、「情感信任」、「認知信任」、「評論可信度」與「選擇意向」。

根據分析結果：「認知信任」和「評論可信度」為高度相關。「評論效價」和「情感信任」、「社會臨場感」和「情感信任」、「社會臨場感」和「認知信任」、「社會臨場感」和「評論可信度」、「情感信任」和「認知信任」、「情感信任」和「評論可信度」等兩兩變項之間的關係為中度相關。其餘變項間的關係為低度相關，或在統計上未顯著相關[4]。所有變項間詳細的相關分析結果如表 4-3 所示。

[4] 相關係數 .3 以下為低相關，.3 - .7 為中等相關，.7 以上為高度相關

doi:10.6342/NTU202300441

表 4 - 3 相關分析

	M	*SD*	1	2	3	4	5	6	7	8
1 身份線索	-	-	1							
2 經驗線索	-	-	.000	1						
3 評論效價	-	-	.000	.000	1					
4 社會臨場感	4.93	0.98	.037	.067	-.013	1				
5 情感信任	4.41	1.18	-.053	.104**	.439**	.434**	1			
6 認知信任	3.85	1.18	-.028	.189**	.085*	.386**	.621**	1		
7 評論可信度	4.69	1.17	-.004	.131**	-.013	.473**	.553**	.762**	1	
8 選擇意向	3.38	1.31	.000	.000	.000	.157**	.043	.036	.142*	1

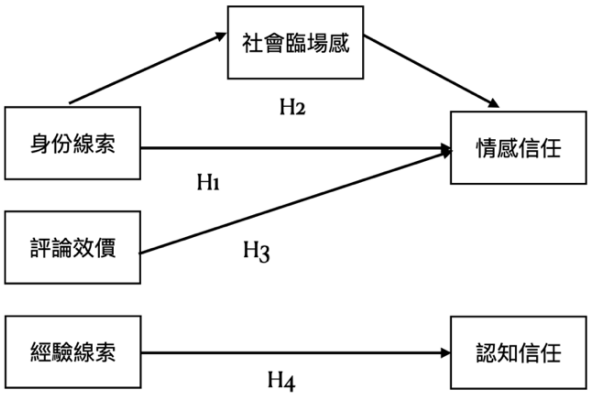
註： $*p < 0.05$, $**p < 0.01$；雙尾檢定

doi:10.6342/NTU202300441

第四節 假設驗證

由於研究為組內實驗設計，且會重複測量觀察值，因此採用混合線性模型（Linear mixed model, LMM），依據研究架構中的變項及研究假設進行資料分析。在此一小節，將先針對第一個研究問題「社會線索的呈現會如何影響使用者對評論者的感知」，與第一個模型（詳如圖 4-1）中相關的四個研究假設（H1-H4）依序進行驗證分析。再針對第二個研究問題「使用者對評論者的信任，會如何影響使用者對評論可信度的感知，及其對使用者選擇醫師的影響」，與第二、第三個模型中的研究假設（H5a, H5b, H6）進行驗證。

圖 4 - 1 研究假設之模型一



H1: 評論者資訊中身份線索的豐富程度，會影響使用者對評論者的情感信任

H2: 使用者對評論者感知的社會臨場感，會中介身份線索與情感信任間的關係

H3: 評論效價會影響使用者對評論者的情感信任

H4: 評論者資訊中的經驗線索，會影響使用者對評論者的認知信任

一、研究假設一：身份線索於情感信任的作用

由於過去於線上環境中的研究發現多顯示身份線索的提供有助於提升使用者對互動對象的信任，因此我們相信，即使在維持一定匿名性的情形下，於評論環境中提供身份線索的豐富程度也會影響使用者對互動對象的信任，故提出研究假設一：「評論者資訊中身份線索的豐富程度，會影響使用者對評論者的情感信任」。

doi:10.6342/NTU202300441

針對研究假設一，於此以「情感信任」作為依變數，同時將「身份線索」置入混合線性模型進行分析，根據分析結果顯示：「身份線索」對「情感信任」未有顯著影響（$\beta = .127$, $p = .177$, *Pseudo R-Square = .003*）（詳見表 4-4），和預期地不同，**H1 不成立：評論者資訊中身份線索的豐富程度不會影響使用者對評論者的情感信任。**對於身份線索為何與預期地作用不同，將於第六節深入討論。

表 4 - 4 身份線索對情感信任作用之線性混合模型摘要

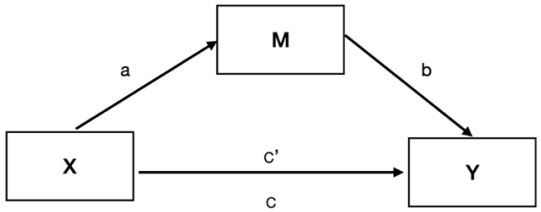
					95% 信賴區間	
	β	*df*	*t* 值	*p* 值	下界	上界
截距	4.342	638	65.624	<.001	4.212	4.472
身份線索	.127	638	1.353	.177	-.057	.310

依變數：情感信任

二、研究假設二：社會臨場感作為中介變項

基於社會臨場感相關的研究顯示，身份線索的提供可望提升使用者對互動對象感知的社會臨場感，而使用者感知社會臨場感的強度，也和使用者在線上環境中的信任相關，故本研究提出研究假設二：「使用者對評論者感知的社會臨場感，會中介身份線索與情感信任間的關係」。中介變項意指當 X 變項對 Y 變項產生的影響（路徑 c），在加入了變項 M 之後，X 變項對 Y 變項的影響（路徑 c'）明顯地減弱，且 X 變項對變項 M（路徑 a）、變項 M 對變項 Y 皆有顯著影響（路徑 b），則 M 變項稱為 X 與 Y 變項之間的中介變項，如圖 4-2 所示。

圖 4 - 2 中介變項概念示意圖

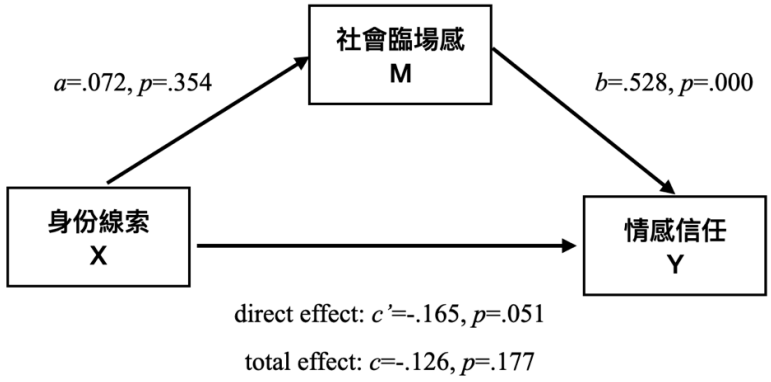


doi:10.6342/NTU202300441

經前述分析，雖已知「身份線索」與其他任一變項皆無相關，且「身份線索」對「情感信任」未有顯著影響，可知研究假設二不成立。但仍於此依據原先的假設檢視「身份線索」、「社會臨場感」與「情感信任」的關係。

對於研究假設二社會臨場感的中介效果，本研究使用 Hayes（2013）開發的 PROCESS 套件的 Model 4，透過拔靴法（bootstrapping）進行檢驗，分析的結果整理如圖 4-3 所示。分析結果顯示「身份線索」對「社會臨場感」未有顯著影響（$\beta = .072, p = .354$），而「社會臨場感」對「情感信任」具有顯著影響（$\beta = .528, p = .000$），當同時考量「身份線索」與「社會臨場感」對「情感信任」的作用，分析結果顯示「身份線索」與「社會臨場感」對「情感信任」（$\beta = -.126, p = .177$）並無顯著影響，若在未考量「社會臨場感」的情形下檢驗「身份線索」與「情感信任」間的關係，結果顯示「身份線索」對「情感信任」未有顯著影響（$\beta = -.165, p = .051$）。

圖 4 - 3 社會臨場感作為中介變項之分析



綜合上述分析結果，可知 **H2 不成立：「社會臨場感」未中介「身份線索」與「情感信任」間的關係**。雖研究假設二不成立，不過，我們發現「社會臨場感」對「情感信任」有顯著的正向影響（$\beta = .525, p < 0.001$），顯示受試者感知評論者的社會臨場感程度越高，仍會明顯提升對評論者的情感信任。

doi:10.6342/NTU202300441

三、研究假設三：評論效價於情感信任之作用

基於使用者會擷取線索形成對互動對象的印象，研究者推測評論者提供正面或負面的評價，也會直接或間接影響使用者對評論者的印象，但不會影響使用者推測評論者的能力，故提出研究假設三：「評論效價（即正負評）會影響使用者對評論者的情感信任」。

針對研究假設三，於此以「情感信任」作為依變數，同時將「評論效價」置入混合線性模型進行分析，根據分析的結果顯示：「評論效價」對「情感信任」具顯著影響（β= -1.039, p < .001, *Pseudo R-Square* = .193）（詳見表 4-5）。即當評論者撰寫的評論為正面評價時，受試者對該評論者的情感信任程度較高，受試者閱讀評論者提供的負面評論時，受試者對評論者的印象也有負向影響。故 **H3 成立：評論效價會影響使用者對評論者的情感信任**。

表 4 - 5 評論效價對情感信任作用之線性混合模型摘要

					95% 信賴區間	
	β	*df*	*t* 值	*p* 值	下界	上界
截距	4.925	638	82.723	<.001	4.808	5.042
評論效價	-1.039	638	-12.341	<.001	-1.204	-.874

依變數：情感信任

四、研究假設四：經驗線索對認知信任之作用

基於多數線上評論的研究結果均顯示：透露評論者對評論商品經驗的線索會讓使用者更信任該評論，或覺得該評論更有幫助。為得知經驗線索是否於信用型商品的情境中仍具有相似作用，故提出研究假設四：「評論者資訊中的經驗線索，會影響使用者對評論者的認知信任」。

針對研究假設四，於此以「認知信任」作為依變數，將「經驗線索」置入線性混合模型進行分析，分析結果顯示：「經驗線索」對「認知信任」有顯著影響（β= -.446, p < 0.001, *Pseudo R-Square* = .036）（詳見表 4-6）。意即當評論者資訊中提供的

doi:10.6342/NTU202300441

經驗線索顯示評論者具較高比例的牙科評論經驗時，會顯著提升受試者對評論者的認知信任。反之亦然，當評論者的評論歷史顯示該評論者過去分享牙科評論經驗的比例相對較低時，經驗線索的呈現也會明顯降低受試者對該評論者的認知信任。故**H4 成立：經驗線索（評論者的評論歷史）會影響使用者對評論者的認知信任**。

表 4 - 6 經驗線索對認知信任作用之線性混合模型摘要

					95% 信賴區間	
	β	*df*	*t* 值	*p* 值	下界	上界
截距	4.074	638	62.933	<.001	3.947	4.201
經驗線索	-.446	638	-4.872	<.001	-.626	-.266

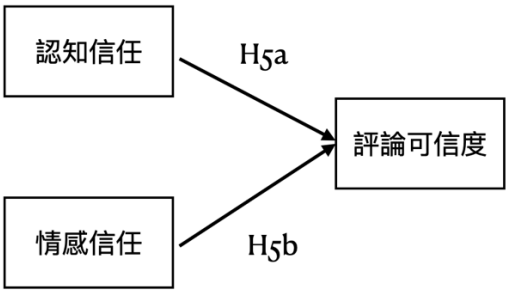
依變數：認知信任

五、研究假設五：信任的轉移

除了藉由區分不同面向的信任，以得知不同類型的社會線索對不同面向信任的作用有何不同外。基於傳統口碑傳播研究中，傳播者往往被視為是影響傳播有效的關鍵，在線上評論的研究中，資訊來源也被認為是判斷消息來源是否可信最重要的指標。本研究也對信任的不同面向如何影響評論可信度，及使用者對評論者與評論間的信任能否轉移感到好奇，為得知信任於不同對象之間的關係，及信任是否可以轉移，於此提出研究假設五（如圖 4-4）：「使用者對評論者的認知信任，會影響使用者對評論可信度的感知」、「使用者對評論者的情感信任，會影響使用者對評論可信度的感知」。

doi:10.6342/NTU202300441

圖 4 - 4 研究假設之模型二



針對研究假設五，分別將「認知信任」、「情感信任」、置入模型進行分析，根據分析的結果顯示：「認知信任」對「評論可信度」有顯著影響（$\beta = .825, p < 0.001$）（詳見表 4-7 的 M1），**H5a 成立：使用者對評論者的認知信任會顯著地影響使用者感知評論可信的程度**。而「情感信任」對「評論可信度」也有顯著影響（$\beta = .595, p < 0.001$）（詳見表 4-7 的 M2），故 **H5b 也 成立：使用者對評論者的情感信任會影響使用者感知評論可信度的程度**。

為了得知「認知信任」與「情感信任」何者對「評論可信度」有較大的影響，研究者亦將「認知信任」與「情感信任」同時置入模型分析，分析結果如前猜想，「認知信任」對「評論可信度」有較大的影響（詳見表 4-7 的 M3）。

表 4 - 7 評論可信度之線性混合模型摘要

變數	M1	M2	M3
認知信任	.825**		.738**
情感信任	-	.595**	.139**
Pseudo R-Square	.581	.306	.591
依變數：評論可信度			

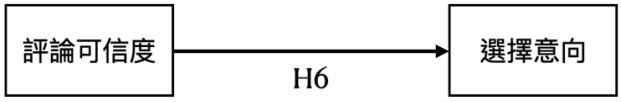
†$p < 0.05$, *$p < 0.01$, **$p < 0.001$

doi:10.6342/NTU202300441

六、研究假設六：信任對選擇的影響

基於多數線上評論研究結果均顯示，使用者對評論的信任會影響使用者對商家的好感或購買商品的意願。為了驗證此關係是否存在於醫師評價的使用情境中，於此提出研究假設六：「使用者感知評論的可信度會影響使用者選擇醫師的意向」。

圖 4 - 5 研究假設之模型三



針對研究假設六，由於正面評價預期的效果為推薦、負面評價為不推薦，兩種評論對於選擇意向的影響方向不同，故將在正評、負評情境下的觀察值分開比較。首先，先以「選擇意向」作為依變數，將在正評情況下測量的「評論可信度」置入模型中進行分析，再將在負評情況下測量的「評論可信度」置入模型中進行分析。分析結果顯示：**在閱讀正評的情況下，「評論可信度」對「選擇意向」有顯著的正向影響**（β = .374, p < .001, *Pseudo R-Square* = .133）。不過，**在閱讀負評的時候，「評論可信度」對「選擇意向」僅有些微負面影響，且在統計上未達顯著效果**，該模型的解釋力也較低（β = -.083, p = .151, *Pseudo R-Square* = .006）。根據分析的結果，**H6 僅部分成立：在正評情況下，使用者對評論可信度的感知，會對使用者選擇醫師的意向有正向影響。但是在負評情形下，使用者對評論可信度的感知，則對使用者的選擇意向沒有顯著影響。**

doi:10.6342/NTU202300441

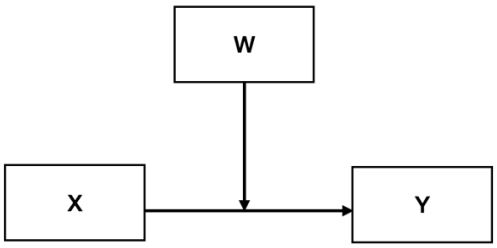
第五節 探索性分析

一、身份線索與評論效價之間的交互作用

如前所述，在線上評論的使用情境下，評論效價可以說是對使用者最直接和最有影響力的資訊（Ba & Pavlou, 2002；Kusumasondjaja et al., 2012），可能會從根本上改變使用者對社會線索的認知與解讀，因此，雖然未事先提出假設，研究者仍預期研究中的三個變項可能會產生交互作用。

交互作用意指：X 變項對 Y 變項產生影響的程度或方向，會因為加入了變項 W 而產生改變，則變項 W 被稱為調節變項（moderator），如圖 4-6 所示。以下將說明研究者對變項間的交互作用進行探索性分析的結果與發現。

圖 4 - 6 調節變項概念示意圖



同樣地，於此也以混合線性模型進行分析，研究者先後將「情感信任」、「認知信任」作為依變數，再將「身份線索」、「評論效價」同時置入模型進行分析，分析結果顯示：「身份線索」與「評論效價」確實存在交互作用，數值詳如表 4-8 所示，為便於理解，將變項間的交互作用效果繪製如圖 4-7 至圖 4-9 所示。

根據分析的結果顯示，在閱讀正面評論的情況下，受試者對身份線索較豐富的評論者有較高程度的情感信任和認知信任。有趣的是，在閱讀負面評論的情況下，受試者反而對提供較少身份線索的評論者有較高的情感信任與認知信任。

doi:10.6342/NTU202300441

表 4 - 8 身份線索與評論效價交互作用之線性混合模型摘要

變數	*β*	*p*	*Pseudo R-Square*
Model 1 身份線索 x 評論效價 → 情感信任			
Model 1			.216
截距	5.030		
身份線索	.209	.75(ns)	
評論效價	-1.375	<.001**	
身份線索*評論效價	.672	<.001**	
Model 2 身份線索 x 評論效價→ 認知信任			
Model 2			.021
截距	4.053		
身份線索	-.203	.121	
評論效價	-.470	<.001**	
身份線索*評論效價	.539	.004*	

†$p < 0.05$, *$p < 0.01$, **$p < 0.001$

圖 4 - 7 身份線索作為調節變項示意圖

doi:10.6342/NTU202300441

圖 4 - 8 身份線索與評論效價於情感信任的交互作用

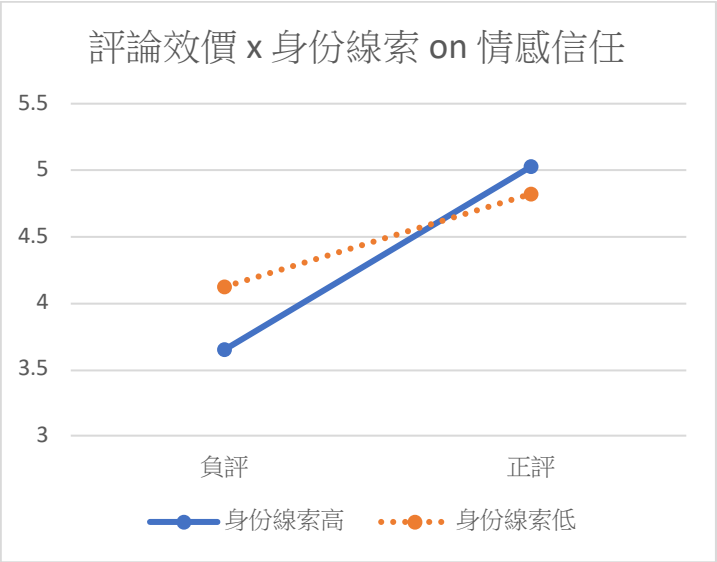
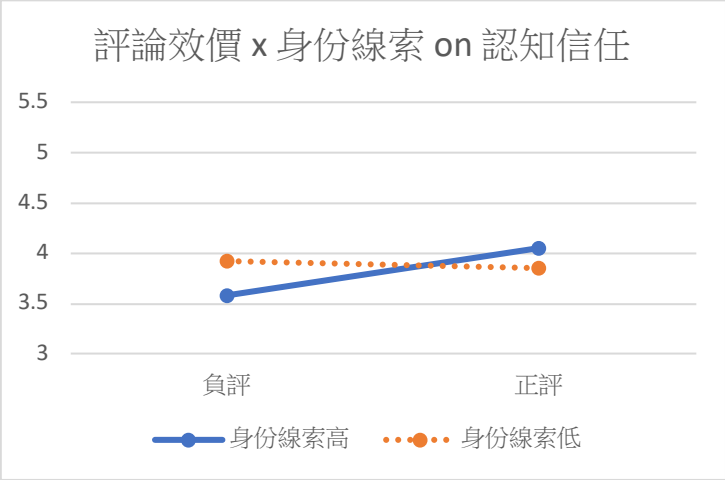


圖 4 - 9 身份線索與評論效價於認知信任的交互作用



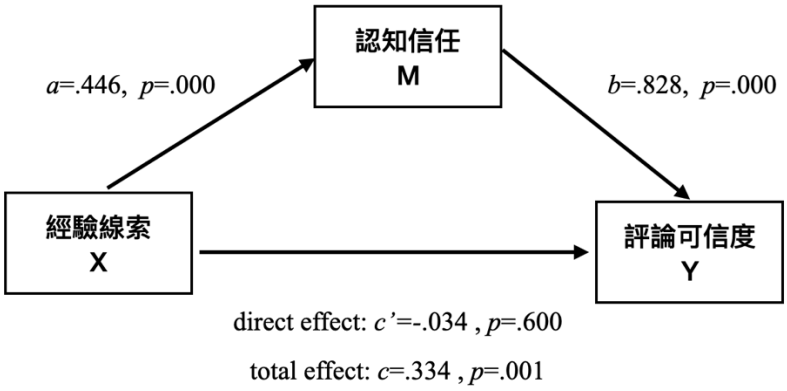
二、認知信任於經驗線索與評論可信度間的中介效果

基於對信任轉移的興趣，與先前在驗證 H4、H5a、H5b 的發現：「經驗線索」對「認知信任」有顯著影響，而使用者對評論者的「認知信任」和「情感信任」也會轉移到對「評論的可信度」上。因此，研究者於此挑選對「評論的可信度」有較大影響力的變項：「認知信任」，及影響認知信任的線索：「經驗線索」，並檢視「經驗線索」、「認知信任」與感知「評論可信度」之間的關係。在這裡，研究者同樣透過

doi:10.6342/NTU202300441

Hayes（2013）開發的 PROCESS 套件的 Model 4，透過拔靴法（bootstrapping）進行檢驗，分析的結果整理如圖 4-10 所示。

圖 4 - 10 認知信任作為中介變項之分析



利用 PROCESS 檢驗的結果與先前以混合線性模型進行的分析結果一致，分析結果顯示「經驗線索」對「認知信任」有顯著影響（路徑 a = .446, p = .000），「認知信任」對「評論可信度」也有顯著影響（路徑 b = .828, p = .000）。同時考量「經驗線索」與「認知信任」對「評論可信度」的作用時，分析結果顯示「經驗線索」與「認知信任」對「評論可信度」（路徑 c = .334, p = .001）有顯著影響，若是在未考量「認知信任」的情形下檢驗「經驗線索」與「評論可信度」的關係，則發現「經驗線索」對「評論可信度」的影響力明顯地減弱（路徑 c' = -.034, ns）。根據上述分析結果，可推論「認知信任」於此具有部分中介效果。

doi:10.6342/NTU202300441

第六節 小結與討論

一、小結

本研究由醫師評價網站的匿名性議題與可供判斷資訊不足的問題出發，希望能藉由執行此研究，更進一步理解使用者在匿名的醫師評價網站環境中，是如何評估和判斷陌生的資訊來源是否可信，而提供哪些社會線索有望成為有用的資訊線索，並提升使用者對線上醫師評論的信任。

本研究發展並設計了 2x2x2 的組內實驗設計，以尋求牙醫為實驗情境，對於「社會線索的呈現會如何影響使用者對評論者的感知」與「使用者對評論者與評論的信任會如何影響使用者的選擇決策」此二研究問題及相關的研究假設進行研究與探討。並邀請了 80 位年齡介於 21 至 30 歲之間，且在近三個月內曾有使用線上評論經驗的年輕人實際參與實驗。

根據實驗蒐集資料進行分析的結果，研究發現：在實驗設計的情境（找牙醫），身份線索的呈現對受試者並無任何作用與影響，除了未在實驗中觀察到身份線索對受試者感知評論者情感信任的作用，身份線索也不會影響受試者感知評論者的社會臨場感，不過，受試者對評論者感知的社會臨場感，會影響受試者對評論者的情感信任。評論效價和經驗線索二者的呈現則分別會影響受試者對評論者的情感信任與認知信任。而使用者對評論者的信任也會影響使用者對評論可信度的感知，其中，對評論者的認知信任會對感知評論可信有較大影響。而受試者對評論可信度的感知只在正評的情形下，會顯著地影響受試者最後選擇醫師的意向，在負評的情形下，則僅有些微負面的影響，但在統計上未達顯著。於此，彙整研究假設驗證的結果如表 4-9。

表 4 - 9 研究假設驗證結果一覽表

研究假設	研究假設內容	結果
H1	評論者資訊中身份線索的豐富程度，會影響使用者對評論者的情感信任	不成立

doi:10.6342/NTU202300441

研究假設	研究假設內容	結果
H2	使用者對評論者感知的社會臨場感，會中介身份線索與情感信任間的關係	不成立
H3	評論效價會影響使用者對評論者的情感信任	成立
H4	評論者資訊中的經驗線索，會影響使用者對評論者的認知信任	成立
H5a	使用者對評論者的認知信任，會影響使用者對評論可信度的感知	成立
H5b	使用者對評論者的情感信任，會影響使用者對評論可信度的感知	成立
H6	評論可信度會影響使用者的選擇意向	部分成立

此外，基於對身份線索反映的匿名性程度與評論效價之間關係的興趣，本研究亦做了探索性的分析，並證實身份線索與評論效價於情感信任、認知信任之間存在交互作用。在正評情形下，受試者對身份線索較豐富的評論者，有較高程度的情感信任與認知信任，不過，在負評的情形下，受試者反而對身份線索較缺乏（匿名性程度較高）的評論者，有較高程度的情感信任與認知信任。身份線索與評論效價之間的交互作用，可以說是本次研究發現中最為有趣，且值得進一步深入探討的研究發現。

二、綜合討論

與原先的假設不同，依據實驗分析的結果，在維持一定匿名性的使用情形下，評論者資訊中身份線索的豐富程度，對於情感信任和社會臨場感此二變項均無任何影響。不過，與先前 Lim 與 Van Der Heide（2015）的研究發現相似，評論效價確實會影響使用者對評論者的信任。在未考慮評論者提供的身份線索情形下，使用者在閱讀正面評論時，會對評論者有較高的情感信任。

而即使在信用型產品（醫療服務）的情境下，經驗線索的呈現與影響也與過去相關研究的主流發現一致（Craciun & Moore, 2019；Liu & Park, 2015），雖然在實驗

doi:10.6342/NTU202300441

設計的呈現中，經驗線索未明確標示評論的數量，僅以比例的形式表示，經驗線索的標示仍讓使用者對評論者有較高程度的認知信任。

其中可說是最為有趣且值得更進一步深入研究的發現是，若同時考量評論效價與評論者身份線索揭露程度的差異，使用者在正評和負評的情形中，似乎會對身份線索有不同的認知與解讀。

在閱讀正面評論的情形下，使用者對身份線索揭露較多的評論者有較高的情感信任與認知信任。不過，在閱讀負面評論時，使用者則對身份線索揭露較少（匿名程度較高）的評論者有較高程度的情感信任與認知信任。研究者猜測造成此一結果的原因可能是由於人們在匿名的情形下，較願意發表自己真實的想法，因此，也會認為發表負評而匿名程度較高的評論者更可信。此外，在一般人的認知中，商家以灌水方式操縱評論多半是為了獲取更高的評價集合，因此在正評情形下，匿名程度較高的評論者更有可能被認為是商家操縱的評論，因而平均獲得較低程度的信任。不過，這僅是研究者的推測，在未來仍需進一步設計相關研究以獲得證據支持，或釐清此二變項之間的關係及背後的運作機制。

本研究原立基於 Walther（1992）提出的社會訊息處理理論與既有的研究發現（Dai et al., 2018；Hu et al., 2008），認為使用者會擷取環境中的線索去推測互動對象是否值得信賴而發展了相關的研究設計和假設。然而，根據實驗結果，在本研究的實驗設計中，並未觀察到身份線索對使用者的感知造成直接的影響。研究者在重新檢閱相關文獻後，依據實驗資料分析、實驗後簡短訪談的結果及相關的研究發現，於此對於造成此一實驗結果的原因，推測有以下幾種可能。

首先，在實驗設計方面，為了讓使用者能在較接近平時使用、瀏覽評論的情形下進行實驗，且避免實驗中途對實驗刺激物進行操縱檢測（manipulation check）的問題干擾或引導使用者對線索的注意力，故本研究並未在實驗中對受試者進行操縱檢測（manipulation check）。雖然在實驗前，本研究已事先透過前測確認身份線索的呈現確實有可辨識身份程度的高低差異，不過，仍有不少受試者在實驗後的訪談中表示，他們在實驗過程中沒有注意到不同評論者的身份線索呈現存在差異。

doi:10.6342/NTU202300441

因此，考量實驗實施的情形，研究者認為對於未能透過實驗觀察到身份線索對使用者感知造成影響的原因，可分為三個面向進行討論：受試者未注意身份線索的呈現、受試者不在意身份線索的呈現，和身份線索的呈現未能使受試者留下記憶。

在實驗設計上，可能因為實驗情境的設定、任務的引導說明和實驗素材的選擇上仍有思考不夠周延之處，因而未能讓使用者有足夠的誘因去注意身份線索。雖然在正式實驗前，研究者皆會請受試者詳細閱讀實驗網站上提供的資訊，再根據實驗網站上的資訊進行填答，並選擇較容易想像和引起共鳴的就醫需求作為實驗情境。然而，受試者只是在想像的需求下瀏覽評論，在不是真正要獲取資訊，以降低決策風險的情形下，無法排除因實驗設計的情境選擇或是任務引導說明，**未能讓受試者產生足夠強烈的代入感**，而使得受試者未注意身份線索呈現的可能。

此外，雖既有研究指出使用者會注意和擷取環境中的線索，以形成對互動對象或推測對象的印象（Dai et al., 2018；Hu et al., 2008），不過，根據 Lim 與 Van Der Heide（2015）的說法，使用者只在推測對象較為可疑時，才會注意、或取用周遭的線索輔助判斷。因此，研究者推測受試者之所以未注意身份線索的呈現，也可能是因為實驗中使用的**評論素材相對可信度較高**（$M = 4.39$），在不需要其他線索輔助的情形下，使受試者在實驗中未注意、取用身份線索。

除實驗設計的瑕疵可能導致受試者未注意身份線索的呈現，研究者推測受試者之所以未注意或不在意身份線索的呈現，也可能受到**受試者過去的使用經驗**影響。由於本次參與實驗的受試者普遍擁有較豐富的使用線上評論經驗（平均值為 8.61，最大值為 10），而在多數使用線上評論的情境中，使用者皆需瀏覽大量的評論再自行彙整、萃取對自己有幫助的資訊，因此，研究者推測過去使用線上評論的經驗可能讓受試者已經相當習慣快速瀏覽大量評論，只專注於比較評論內容的優劣，和評論內容敘述的情況是不是與自身條件接近，因而在實驗中閱讀評論的過程會自動忽略評論者的身份資訊，也就不會將評論者的身份線索納入評估是否可信和是否要採納評論的評斷標準。

而受試者過去浸潤的使用環境，可能也是造成受試者未注意、或是不在意身份線索的原因。由於在台灣尚未有專門且普及的醫師評價網站，多數的受試者皆提及

doi:10.6342/NTU202300441

他們獲取醫師資訊的方式，除了透過醫院或診所提供的官方資訊外，多透過 PTT、Dcard 查找網友對醫師的評價。PTT 與 Dcard 屬於台灣頻繁使用的社群媒體，二者皆為匿名設計，從平台的使用人數與黏著程度，可知此二平台皆為台灣年輕族群日常獲取資訊與休閒娛樂的重要管道，**線上環境中的匿名使用，在台灣可能已成為一種社會常規（social norms）**。正如同 Broeder（2022）於線上評論中的研究發現：同樣的身份線索（照片）對於不同國家文化（荷蘭、日本）的使用者，具有程度不等的影響力。在本研究中受試者過去於線上環境中互動的慣習與文化，可能也讓受試者相對熟悉匿名設計的互動與資訊獲取方式，因而不注意、或是不在意評論者的身份為何。

雖然身份線索的提供，對提升使用者對線上環境中互動對象的信任，已在電子商務、線上論壇、共享經濟等不同的線上互動情境中獲得廣泛的研究支持（Fu et al., 2022；Ma et al., 2017；Steinbrück et al., 2002）。不過，不同於既有研究多以身份線索提供的有無進行討論，本研究主張匿名性與身份揭露不是一個全有或全無的概念，而是一連續性的概念，因而使用維持一定匿名性但略可辨識身份的線索作為實驗的刺激物。而過去使用身份線索作為刺激物的相關研究，多使用正面半身照片（Ert et al., 2016；Lee & Shin, 2014；Xu, 2014），或多元的身份線索：除 ID 或頭像外，甚至還包含地點、興趣合併呈現（Mudambi & Schuff, 2010；Toma, 2010）。

再加上根據心理學的相關實驗研究發現，當人們在被要求進行指定任務時，較容易忽略其他資訊；另一方面，也可能因為訪談時距離受試者閱讀評論的時間有段間隔，在未形成強烈印象的情形下，導致受試者無法順利回憶實驗素材間的差異。由於無法辨別受試者的情況屬於上述何者，故在資料分析階段也未剔除任何資料。根據實驗設計的情境與實驗實施情形，研究者推測**實驗設計中身份線索的呈現不夠立體、充足和多元**，也可能是造成實驗結果與過去研究發現不一致的重要原因。

在實驗後的訪談，有部分受試者提及，他們雖然有注意到不同評論者的頭像與 ID 不同，但他們主觀認為身份線索的差異，不會影響他們判斷評論是不是可信，也不會影響他們要不要採納該評論者的評論與建議。在重新檢閱過去與身份線索相關的研究後，研究者認為身份線索的提供之所以在既有研究中對提升互動對象的信任

doi:10.6342/NTU202300441

有幫助，可能是由於在特定的研究情境中，提供身份線索背後所透露的訊息，能讓使用者有進一步發展對推測對象想像的依據，例如：在 Airbnb 的使用情境，在個人資訊頁中透露房屋主人的興趣，可能可以讓使用者推測屋主的個性、品味等（Ma et al., 2017）。在 LinkedIn 的使用情境中，使用者對身著專業服裝的頭像，可能會有更進一步推測互動對象的工作情形，或是對互動對象於職場中的位置的想像（Edwards et al., 2015）。換言之，在這些使用情境中，身份線索的提供之所以能讓使用者更加信任線上環境中的陌生互動對象，是因為身份線索透露的是**相關且有用的線索**。而在本研究使用的身份線索（透露興趣的頭像和 ID），與看牙醫之間並無明顯相關。

另一個可能的原因，則是身份線索的提供，讓使用者發現自身與互動對象之間的**相似性（similarity）**，在過去對線上評論的研究中，有許多研究指出和評論者之間的相似性會增強使用者對評論的採納。在本研究中，雖然使用可推測評論者興趣的頭像作為身份線索，不過，研究中並未調查受試者的興趣，因而無法驗證此一猜測是否準確。

最後，根據實驗後訪談和重新檢視既有研究發現後，我們認為使用者是否**預期和評估對象有後續的互動**，則是另一項影響使用者感知和應用身份線索，以對互動對象評估信任的關鍵。部分受試者在分享日常使用線上評論的經驗時，表示評論者（在 Google Maps 的評論裡）是否有在地嚮導的徽章會是他們關注和衡量的依據，但他們不會特意關注評論者的身份，僅有少數受試者提及他們記得某些特別活躍的評論者帳號。由於本研究的實驗設計僅為單次測試，受試者對這些身份線索的呈現也僅有單次的印象，和過去對於社會臨場感及身份線索影響信任的研究設定的使用情境差異較大（Bacev-Giles & Haji, 2021；Feng et al., 2016；Fu et al., 2022）。依據 Rains 與 Scott（2007）的說法，有無後續互動的可能，也會影響使用者辨識互動對象的意願動機（desire）與意圖（intention）。

總結來說，除實驗設計可能讓受試者未有足夠強烈的代入感和涉入程度，因而未注意身份線索的呈現。在線上評論的使用情境中，使用者也可能因為過去的使用經驗與文化因素，或是相對缺乏與評論者互動的期待與意圖，因而影響使用者辨識評論者身份的動機而不在意身份線索的呈現。最後，身份線索所透露的資訊，以及

doi:10.6342/NTU202300441

使用者如何解讀身份線索則可能是另一項影響的關鍵，身份線索的呈現是不是足夠立體且與推測對象相關，以及身份線索透露的資訊與使用者之間是否具有一定程度的相似性，也是研究者認為可能影響使用者取用、應用身份線索的原因。

doi:10.6342/NTU202300441

doi:10.6342/NTU202300441

第五章 結論

本章節共分為三個小節，第一節將依據前述資料分析的結果，綜整研究發現，回應研究問題。第二節將根據實驗的結果，與歸納相關文獻的發現和建議，提出對醫師評價網站的設計、營運方向的實務建議。第三小節將歸納本研究的侷限，說明研究發現的可應用範圍，並提出未來研究的潛在可能，及未來可以如何改善、擴展研究的方向。

第一節 發現與貢獻

在線上評論的研究中，信用型商品（醫療服務）是相對少被研究探討的對象，在此之前，我們對其他線上評論的研究發現是否能應用至信用型商品仍處於未知。而醫師評價網站相關的研究和討論中，則有不少對評價網站是否應該做更多的身份驗證以避免醫師的名譽被損害，或是維持匿名設計以避免醫病關係受到評論影響的爭論。

站在醫師評價網站應維持匿名評論設計的立場，本研究的第一個研究問題，即為探討不同類型的社會線索會如何影響使用者對評論者的感知，並特別關注於身份線索的呈現和其反應的匿名性是否會影響使用者的感知，及在信用型商品的類型下，經驗線索的呈現會對使用者的信任造成何種影響。第二個研究問題，則進一步追問使用者對評論者的感知，會對使用者的醫師選擇決策有何影響。

研究發現身份線索不是會直接影響使用者信任的元素，但會些微地調節使用者在正評和負評情形下對評論者的信任。醫療服務雖然具有強烈的信用型產品特質，一般使用者無法透過親身經驗而能夠判斷服務的好壞，然而，透過此研究發現，在醫師評價網站的使用情境，經驗線索所透露評論者的經驗豐富與否，仍顯著地影響使用者對評論者的認知信任。

不過，使用者對評論的可信度僅在正評情形下對使用者的選擇意向有明顯影響，意味使用者對負面評論的採納與否更多持保留看法，傾向將評論者的負面意見歸因於個體間的差異，此發現也與過去的研究發現相互呼應（Sen & Lerman, 2007）。

doi:10.6342/NTU202300441

第二節 實務建議

在台灣，雖仍未有專門且普及的醫師評價網站，但是藉由國外的發展與經驗，我們可以知道醫師評價網站的設立與使用，不論對一般大眾獲取醫師資訊、對醫師更了解病患的感受與改善醫療服務品質、或整體醫療環境資訊的透明，都能有正面的幫助和影響。於此，將結合研究者閱讀相關文獻所知與本研究的發現，對於設立與營運醫師評價網站提出建議，供給各方參考。

首先，基於本研究的實驗結果，身份線索在醫師評價網站的使用情境中，相對不是重要的社會線索，使用者可能不會注意或在意此一資訊的呈現，因此，本研究建議未來欲著手進行醫師評價網站的設計者、或仍在權衡是否應採用身份驗證機制或維持匿名設計的政策決策者，可參酌本研究的實驗結果，對於身份呈現的設計，選擇可保護評論者隱私的匿名設計，且匿名評論的機制也可以同時兼顧提升大眾於線上環境中分享自身真實看法的意願（Deng et al., 2021；Rains, 2007）。

本研究的實驗設計使用評論者過去於特定科別的評論歷史比例來表示評論者的經驗，且實驗發現此一資訊線索的呈現，會影響使用者推測評論者是否可靠和值得信賴，並進而影響使用者看待評論的可信度。因此，本研究建議，在醫師評價網站的評論頁面設計，除了評論內容的提供，也可加上評論者於不同科別的評論歷史，提供一般瀏覽評論的使用者作為判斷決策的依據。

在資訊提供的面向，於此借用 Nelson（1970,1974）提出對商品分類的框架進行思考，本研究建議在醫師評價網站上應提供關於醫師或醫院的搜尋性資訊：地點、營業時間、醫師年資、畢業學校等，且引導大眾對於看診的體驗面向進行評論，以讓其他潛在的病患能有不同於官方資訊的資訊可以參考，也讓提供醫療服務的一方可以透過評論認識病患對醫療服務真實的想法，以獲知改善醫療服務流程與品質的可能。除了引導大眾分享自身使用醫療服務的真實經驗和想法外，醫師評價網站也應同時引入官方或第三方公共衛生組織對醫師或醫院診所評鑑、蒐集的客觀資料，讓客觀資料與大眾對醫師的主觀評論並陳，以彌補大眾可能無法準確判斷醫師專業能力的面向。

doi:10.6342/NTU202300441

在醫師評價網站的營運設計上，也可參考既有的研究發現，依據醫師評價網站獲得的評論數量，分階段設計不同的資訊提供方式，以避免單一或少量的負面評論對醫師造成損害。對於虛假評論的議題，則可引入 AI 技術偵測和辨別不實評論，並定期公告成果，以提升使用者對醫師評論網站本身的信賴。

對於提供醫療服務的一方，建議醫師或醫院應定期查看病患對自身醫療服務的評論意見，並適時回覆評論，曾有線上評論的研究指出使用者對願意回覆顧客評論的商家有較高的好感。定期查看評論不僅可增進對病患的理解，了解原先提供醫療服務的流程有哪些可改進之處，適時地回覆評論也能提升潛在顧客對自身的好感，降低負面評論造成的衝擊。

doi:10.6342/NTU202300441

第三節 未來研究方向

由於研究方法的選擇，在研究對象、實驗情境選擇、實驗流程安排、量表選擇與實驗設計上，有些方法上的侷限，於此依序說明，並延伸未來可以改善或進一步研究的方向。

首先，關於研究對象的選擇，本研究選擇 21 至 30 歲的成年人作為研究對象，此族群普遍較少有醫療需求和使用醫療服務的經驗，但在閱讀和利用一般線上評論的經驗較為豐富，也對透過網路獲取資訊較為熟悉。因此，此一年齡層的使用者對網頁上內容的感知及其形成醫療決策的方式，可能會和其他具備不同使用特性、或位於不同年齡層的使用者有些許差異，故在解讀研究發現時，應注意不同使用群體之間的差異，且不宜過度推論至具備不同特性的群體。未來研究可嘗試選擇有較多使用醫療服務經驗的樂齡族群或患有慢性病的群體，可能會有不同的發現。

在實驗情境選擇上，本研究選擇以因突發的智齒痛而產生的醫療需求作為實驗情境，在同樣是尋找牙醫的需求，要進行牙齒矯正、牙周病治療、假牙製作；或由本人、代理人進行醫師資訊的搜尋與醫療決策，可能都會影響受試者的感知，或是願意投入的心力和時間成本。考量研究的規模與可執行人力，本研究未能同時比較不同醫療情境的實驗研究、檢驗情境的差異是否會造成不同的影響。在不同科別或醫療需求的情況下，是否仍適用本研究的發現仍屬未知。在未來，可以依醫療需求的重要、緊急、成本高低等不同面向，或依據醫師專業科別的差異進行更進一步的研究。

在實驗流程方面，由於實驗中要求受試者依序閱讀評論，在每讀完一則評論後，便對受試者測量對個別評論者的感知，包含社會臨場感、情感信任和認知信任，及對評論的判斷。為控制受試者有一致的閱讀順序，可能導致實驗設計的閱讀順序和一般使用者閱讀線上評論、產生對評論者印象與形成最終決策的使用習慣有所不同。例如：部分受試者在實驗後表示，他們傾向大量瀏覽評論後，再進行綜合判斷，而不是閱讀的當下即對單則評論做出判斷。因此，這樣的實驗流程設計可能導致些許無法避免的誤差，為本研究的侷限。

doi:10.6342/NTU202300441

在量表的選擇方面，由於社會臨場感為一具有多重構面的概念，且既有研究中曾發展多種不同的量表對此一概念進行測量，本研究當時選擇了同樣以線上評論為情境進行研究所發展的量表，也因為整體實驗測量規模與題數的考量，捨棄了較為完整的量表設計。因此，在量表的選擇上，倘若未來研究希望能更精確地測量社會臨場感此一變項，可能仍有其他更適合的選擇，可以更全面反映社會臨場感的概念。

在實驗設計方面，為了讓使用者能在較接近自行瀏覽評論的情形下進行實驗，且避免實驗中途的實驗操縱檢測（manipulation check）問題干擾或引導使用者對線索的注意力，因而取消了在實驗中進行注意力檢測問題的設計。雖然在實驗前已事先透過前測確認身份線索的呈現確實有可辨識身份程度的高低差異，但是在實驗後的訪談中，有不少受試者表示他們沒有注意到不同評論者的身份線索呈現存在差異。

不過，根據心理學的相關實驗研究發現，人們被要求進行指定任務時，較容易忽略其他資訊；另一方面，也可能是因訪談時距離受試者閱讀評論的時間有段間隔，受試者因而無法順利回憶起其中的差異。在缺乏其他決策依據的情形下，由於無法辨別受試者的情況屬於上述何者，故在資料分析階段也未剔除任何資料。

因此，研究者認為根據實驗設計的情境與實驗實際實施的情形，對資料分析的結果較適合解讀為身份線索呈現的豐富程度，不足以影響使用者感知評論者的情感信任及社會臨場感。由於實驗設計中身份線索的呈現不夠立體、充足和多元，無法和受試者有足夠的相似性以被標識和記憶，實為實驗設計上的侷限與缺憾。

為了避免類似的情形發生，在未來進行此類不適合在實驗途中進行注意力確認檢測的研究時，可嘗試以眼動追蹤（eye tracking）的方式輔助進行，以確認受試者對畫面上資訊的接收，以辨別受試者究竟是有接收到資訊但沒留下印象，或是完全沒有接收到資訊。此外，以眼動追蹤的方式進行評論研究，也可以增添多元的資料進行分析和判斷，例如：可以進一步分析使用者閱讀評論時的注意力會集中在何處，而視線停留時間的長短對於評論者印象、或評論內容的感受程度是否有別。或透過此一資料，理解使用者在閱讀正面或負面評論時，關注頁面上各類線索的順序是否有所差異。

doi:10.6342/NTU202300441

此外，正如在前述討論段落提及，研究者認為身份線索透露的資訊與推測對象無明顯相關，可能也是造成本研究中身份線索未能如預期發揮作用的原因。在未來的研究中，若仍要以醫師評價網站為情境討論身份線索的呈現，對於實驗刺激物的選擇與醫療需求的搭配，可能可以有更多思考。例如：選擇以寵物生病和尋求獸醫為實驗情境，在身份線索的呈現上，可選擇配合包含寵物在內的頭像照片；或選擇因運動傷害而需要尋找物理治療師作為實驗情境，關於身份線索的呈現，即可選擇能顯示出照片主人有從事相關運動的照片作為頭像。如此一來，身份線索的呈現則可能仍在維持一定匿名性的情況下，與過去的研究有較一致的發現。

最後，對於身份線索與評論效價之間有趣的交互作用，因本研究以實驗為主體，僅能觀察到此一現象的存在，並猜測造成此一現象背後可能的原因。在未來的研究，可能可以嘗試以更詳盡且有組織的訪談，以更深入地挖掘背後的可能，理解使用者在閱讀正面評論或負面評論時，取用線索與解讀線索的過程。或以多元的情境組合設計研究，檢驗身份揭露（匿名性）與評論效價之間的關係。

doi:10.6342/NTU202300441

參考文獻

李旻鴻（2012）。口碑對於病患醫療選購的影響（未出版之碩士論文）。國立臺灣科技大學企業管理系，台北市。

林家圻、邱銘心（2019）。網路醫師資訊之內容分析研究。教育資料與圖書館學，56(2)，163-199。https://doi.org/10.6120/JoEMLS.201907_56(2).0015.RS.AM

邱銘心、張家翎（2015）。網路醫師評價之結構與內容特徵分析研究。教育資料與圖書館學，52(2)，157-190。https://doi.org/10.6120/JoEMLS.2015.522/0001.RS.AM

謝慧欣、鄭守夏、丁志音（2000）。住院病患對就醫選擇資訊之需求：初步調查發現。中華公共衛生雜誌，19(6)，437-445。https://doi.org/10.6288/CJPH2000-19-0604

Azimi, S., Chan, K., & Krasnikov, A. (2022). How fakes make it through: the role of review features versus consumer characteristics. *Journal of Consumer Marketing*, *39*(5), 523–537. https://doi.org/10.1108/JCM-04-2021-4597

Ba, S., & Pavlou, P. A. (2002). Evidence of the Effect of Trust Building Technology in Electronic Markets: Price Premiums and Buyer Behavior. *MIS Quarterly*, *26*(3), 243–268. https://doi.org/10.2307/4132332

Bacev-Giles, C., & Haji, R. (2017). Online first impressions: Person perception in social media profiles. *Computers in Human Behavior*, *75*, 50–57. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.04.056

Ballantine, P. W., & Au Yeung, C. (2015). The effects of review valence in organic versus sponsored blog sites on perceived credibility, brand attitude, and behavioural intentions. *Marketing Intelligence & Planning*, *33*(4), 508–521. https://doi.org/10.1108/MIP-03-2014-0044

Banerjee, S., Bhattacharyya, S., & Bose, I. (2017). Whose online reviews to trust? Understanding reviewer trustworthiness and its impact on business. *Decision Support Systems*, *96*, 17–26. https://doi.org/10.1016/j.dss.2017.01.006

doi:10.6342/NTU202300441

Billinghurst, B., & Whitfield, M. (1993). Why do patients change their general practitioner? A postal questionnaire study of patients in Avon. *British Journal of General Practice*, 3.

Biocca, F., Harms, C., & Burgoon, J. K. (2003). Toward a more robust theory and measure of social presence: Review and suggested criteria. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 12(5),* 456–480.

Broeder, P. (2022). Profile Photos' Impact in Online Reviews: The Effect of Cultural Differences. *Review of Marketing Science*. https://doi.org/10.1515/roms-2021-0074

Brown, J. J., & Reingen, P. H. (1987). Social Ties and Word-of-Mouth Referral Behavior. *Journal of Consumer Research*, *14*(3), 350–362.

Chang, C. (2012). Is that website for me? website-self-congruency effects triggered by visual designs. *International Journal of Advertising*, *31*(4), 835–860. https://doi.org/10.2501/IJA-31-4-835-860

Chang, H. H., & Wu, L. H. (2014). An examination of negative e-WOM adoption: Brand commitment as a moderator. *Decision Support Systems*, *59*, 206–218. https://doi.org/10.1016/j.dss.2013.11.008

Chevalier, J. A., & Mayzlin, D. (2006). The Effect of Word of Mouth on Sales: Online Book Reviews. *Journal of Marketing Research*, *43*(3), 345–354. https://doi.org/10.1509/jmkr.43.3.345

Chiu, M.-H. P., & Chang, C.-L. (2015). What Do Patients of Different Medical Illness Say About Their Doctors Online? An Analysis of Online Physician Reviews. In F. Fui-Hoon Nah & C.-H. Tan (Eds.), *HCI in Business* (pp. 34–40). Springer International Publishing.

Craciun, G., & Moore, K. (2019). Credibility of negative online product reviews: Reviewer gender, reputation and emotion effects. *Computers in Human Behavior*, *97*, 104–115. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.03.010

Cyr, D., Head, M., Larios, H., & Pan, B. (2009). Exploring Human Images in Website Design: A Multi-Method Approach. *MIS Quarterly*, *33*(3), 539–566. https://doi.org/10.2307/20650308

Dai, Y. (Nancy), Viken, G., Joo, E., & Bente, G. (2018). Risk assessment in e-commerce: How sellers' photos, reputation scores, and the stake of a transaction influence

doi:10.6342/NTU202300441

buyers' purchase behavior and information processing. *Computers in Human Behavior*, *84*, 342–351. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.02.038

Deng, L., Sun, W., Xu, D., & Ye, Q. (2021). Impact of Anonymity on Consumers' Online Reviews. *Psychology & Marketing*, *38*(12), 2259–2270. https://doi.org/10.1002/mar.21565

Drevs, F., & Hinz, V. (2014). Who chooses, who uses, who rates: The impact of agency on electronic word-of-mouth about hospitals stays. *Health Care Management Review*, *39*(3), 223–233. https://doi.org/10.1097/HMR.0b013e3182993b6a

Edwards, C., Stoll, B., Faculak, N., & Karman, S. (2015). Social Presence on LinkedIn: Perceived Credibility and Interpersonal Attractiveness Based on User Profile Picture. *Online Journal of Communication and Media Technologies*, *5*(4), 102–115. https://doi.org/10.29333/ojcmt/2528

Emmert, M., & Meier, F. (2013). An Analysis of Online Evaluations on a Physician Rating Website: Evidence From a German Public Reporting Instrument. *Journal of Medical Internet Research*, *15*(8), e2655. https://doi.org/10.2196/jmir.2655

Emmert, M., Meier, F., Heider, A.-K., Dürr, C., & Sander, U. (2014). What do patients say about their physicians? An analysis of 3000 narrative comments posted on a German physician rating website. *Health Policy*, *118*(1), 66–73. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2014.04.015

Emmert, M., Meier, F., Pisch, F., & Sander, U. (2013). Physician Choice Making and Characteristics Associated With Using Physician-Rating Websites: Cross-Sectional Study. *Journal of Medical Internet Research*, *15*(8), e2702. https://doi.org/10.2196/jmir.2702

Emmert, M., Sander, U., & Pisch, F. (2013). Eight Questions About Physician-Rating Websites: A Systematic Review. *Journal of Medical Internet Research*, *15*(2), e2360. https://doi.org/10.2196/jmir.2360

Ert, E., Fleischer, A., & Magen, N. (2016). Trust and reputation in the sharing economy: The role of personal photos in Airbnb. *Tourism Management*, *55*, 62–73. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.01.013

doi:10.6342/NTU202300441

Fang, B., Ye, Q., Kucukusta, D., & Law, R. (2016). Analysis of the perceived value of online tourism reviews: Influence of readability and reviewer characteristics. *Tourism Management*, *52*, 498–506. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.07.018

Feng, B., Li, S., & Li, N. (2016). Is a Profile Worth a Thousand Words? How Online Support-Seeker's Profile Features May Influence the Quality of Received Support Messages. *Communication Research*, *43*(2), 253–276. https://doi.org/10.1177/0093650213510942

Flanagin, A. J., & Metzger, M. J. (2007). The role of site features, user attributes, and information verification behaviors on the perceived credibility of web-based information. *New Media & Society*, *9*(2), 319–342. https://doi.org/10.1177/1461444807075015

Forman, C.A, Ghose, B., Wiesenfeld. (2008). Examining the relationship between reviews and sales: the role of reviewer identity disclosure in electronic markers. *Information System Research, 19 (3)*, pp. 291-313 https://doi.org/10.1287/isre.1080.0193

Fu, H., He, J., Hong, J., & Hu, L. (2022). Trust me if you can: The effect of driver username on passengers' intention to use ride-sharing service. *Journal of Consumer Behaviour*, 1– 14. https://doi.org/10.1002/cb.2085

Gao, G. G., McCullough, J. S., Agarwal, R., & Jha, A. K. (2012). A Changing Landscape of Physician Quality Reporting: Analysis of Patients' Online Ratings of Their Physicians Over a 5-Year Period. *Journal of Medical Internet Research*, *14*(1), e2003. https://doi.org/10.2196/jmir.2003

Gefen, D., & Straub, D. W. (2004). Consumer trust in B2C e-Commerce and the importance of social presence: Experiments in e-Products and e-Services. *Omega*, *32*(6), 407–424. https://doi.org/10.1016/j.omega.2004.01.006

Gershoff, A. D., Mukherjee, A., & Mukhopadhyay, A. (2003). Consumer Acceptance of Online Agent Advice: Extremity and Positivity Effects. *Journal of Consumer Psychology*, *13*(1), 161–170. https://doi.org/10.1207/S15327663JCP13-1&2_14

Ghose, A., & Ipeirotis, P. G. (2011). Estimating the Helpfulness and Economic Impact of Product Reviews: Mining Text and Reviewer Characteristics. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, *23*(10), 1498–1512. https://doi.org/10.1109/TKDE.2010.188

doi:10.6342/NTU202300441

Grabner-Kräuter, S., & Waiguny, M. K. (2015). Insights Into the Impact of Online Physician Reviews on Patients' Decision Making: Randomized Experiment. *Journal of Medical Internet Research*, *17*(4), e3991. https://doi.org/10.2196/jmir.3991

Han, X., Qu, J., & Zhang, T. (2019). Exploring the impact of review valence, disease risk, and trust on patient choice based on online physician reviews. *Telematics and Informatics*, *45*, 101276. https://doi.org/10.1016/j.tele.2019.101276

Hanauer, D. A., Zheng, K., Singer, D. C., Gebremariam, A., & Davis, M. M. (2014). Public Awareness, Perception, and Use of Online Physician Rating Sites. *JAMA*, *311*(7), 734–735. https://doi.org/10.1001/jama.2013.283194

Hassanein, K., & Head, M. (2007). Manipulating perceived social presence through the web interface and its impact on attitude towards online shopping. *International Journal of Human-Computer Studies*, *65*(8), 689–708. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2006.11.018

Hay, M. C., Strathmann, C., Lieber, E., Wick, K., & Giesser, B. (2008). Why Patients Go Online: Multiple Sclerosis, the Internet, and Physician-Patient Communication. *The Neurologist*, *14*(6), 374–381. https://doi.org/10.1097/NRL.0b013e31817709bb

Hayes, A.F. (2013). Introduction to mediation, moderation, & conditional process analysis: A regression-based approach: Guilford Press.

Hennig-Thurau, T., Gwinner, K. P., Walsh, G., & Gremler, D. D. (2004). Electronic word-of-mouth via consumer-opinion platforms: What motivates consumers to articulate themselves on the Internet? *Journal of Interactive Marketing*, *18*(1), 38–52. https://doi.org/10.1002/dir.10073

Hlee, S., Lee, H., Koo, C., & Chung, N. (2021). Fake Reviews or Not: Exploring the relationship between time trend and online restaurant reviews. *Telematics and Informatics*, *59*, 101560. https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101560

Holliday, A. M., Kachalia, A., Meyer, G. S., & Sequist, T. D. (2017). Physician and Patient Views on Public Physician Rating Websites: A Cross-Sectional Study. *Journal of General Internal Medicine*, *32*(6), 626–631. https://doi.org/10.1007/s11606-017-3982-5

doi:10.6342/NTU202300441

Hong, Y. A., Liang, C., Radcliff, T. A., Wigfall, L. T., & Street, R. L. (2019). What Do Patients Say About Doctors Online? A Systematic Review of Studies on Patient Online Reviews. *Journal of Medical Internet Research*, *21*(4), e12521. https://doi.org/10.2196/12521

Howell, E. A., Gardiner, B., & Concato, J. (2002). Do women prefer female obstetricians? *Obstetrics and Gynecology*, *99*(6), 1031–1035. https://doi.org/10.1016/s0029-7844(02)01980-4

Hu, N., Bose, I., Koh, N. S., & Liu, L. (2012). Manipulation of online reviews: An analysis of ratings, readability, and sentiments. *Decision Support Systems*, *52*(3), 674–684. https://doi.org/10.1016/j.dss.2011.11.002

Hu, N., Liu, L., & Sambamurthy, V. (2011). Fraud detection in online consumer reviews. *Decision Support Systems*, *50*(3), 614–626. https://doi.org/10.1016/j.dss.2010.08.012

Hu, N., Liu, L., & Zhang, J. J. (2008). Do online reviews affect product sales? The role of reviewer characteristics and temporal effects. *Information Technology and Management*, *9*(3), 201–214. https://doi.org/10.1007/s10799-008-0041-2

Jain, S. (2010). Googling Ourselves—What Physicians Can Learn from Online Rating Sites. *New England Journal of Medicine*, *362*(1), 6–7. https://doi.org/10.1056/NEJMp0903473

Kadry, B., Chu, L. F., Kadry, B., Gammas, D., & Macario, A. (2011). Analysis of 4999 Online Physician Ratings Indicates That Most Patients Give Physicians a Favorable Rating. *Journal of Medical Internet Research*, *13*(4), e1960. https://doi.org/10.2196/jmir.1960

Korfiatis, N., García-Bariocanal, E., & Sánchez-Alonso, S. (2012). Evaluating content quality and helpfulness of online product reviews: The interplay of review helpfulness vs. review content. *Electronic Commerce Research and Applications*, *11*(3), 205–217. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2011.10.003

Kusumasondjaja, S., Shanka, T., & Marchegiani, C. (2012). Credibility of online reviews and initial trust: The roles of reviewer's identity and review valence. *Journal of Vacation Marketing*, *18*(3), 185–195. https://doi.org/10.1177/1356766712449365

doi:10.6342/NTU202300441

Lee, E.-J., & Shin, S. Y. (2012). Are They Talking to Me? Cognitive and Affective Effects of Interactivity in Politicians' Twitter Communication. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, *15*(10), 515–520. https://doi.org/10.1089/cyber.2012.0228

Lee, E.-J., & Shin, S. Y. (2014). When do consumers buy online product reviews? Effects of review quality, product type, and reviewer's photo. *Computers in Human Behavior*, *31*, 356–366. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.10.050

Lee, K. M. (2004). Presence, explicated. *Communication Theory, 14(1)*, 27–50.

Li, S., Feng, B., Chen, M., & Bell, R. A. (2015). Physician Review Websites: Effects of the Proportion and Position of Negative Reviews on Readers' Willingness to Choose the Doctor. *Journal of Health Communication*, *20*(4), 453–461. https://doi.org/10.1080/10810730.2014.977467

Lim, Y., & Van Der Heide, B. (2015). Evaluating the Wisdom of Strangers: The Perceived Credibility of Online Consumer Reviews on Yelp. *Journal of Computer-Mediated Communication*, *20*(1), 67–82. https://doi.org/10.1111/jcc4.12093

Lin, J., Lu, Y., Wang, B., & Wei, K. K. (2011). The role of inter-channel trust transfer in establishing mobile commerce trust. *Electronic Commerce Research and Applications*, *10*(6), 615–625. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2011.07.008

Liu, Z., & Park, S. (2015). What makes a useful online review? Implication for travel product websites. *Tourism Management*, *47*, 140–151. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.09.020

López, A., Detz, A., Ratanawongsa, N., & Sarkar, U. (2012). What Patients Say About Their Doctors Online: A Qualitative Content Analysis. *Journal of General Internal Medicine*, *27*(6), 685–692. https://doi.org/10.1007/s11606-011-1958-4

Luca, M., & Zervas, G. (2016). Fake It Till You Make It: Reputation, Competition, and Yelp Review Fraud. *Management Science*, *62*(12), 3412–3427. https://doi.org/10.1287/mnsc.2015.2304

Ma, X., Hancock, J. T., Lim Mingjie, K., & Naaman, M. (2017). Self-Disclosure and Perceived Trustworthiness of Airbnb Host Profiles. *Proceedings of the 2017 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing*, 2397–2409. https://doi.org/10.1145/2998181.2998269

doi:10.6342/NTU202300441

Malik, M., & Hussain, A. (2018). An analysis of review content and reviewer variables that contribute to review helpfulness. *Information Processing & Management*, *54*(1), 88–104. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2017.09.004

Manes, E., & Tchetchik, A. (2018). The role of electronic word of mouth in reducing information asymmetry: An empirical investigation of online hotel booking. *Journal of Business Research*, *85*, 185–196. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.12.019

Martinez-Torres, M. R., & Toral, S. L. (2019). A machine learning approach for the identification of the deceptive reviews in the hospitality sector using unique attributes and sentiment orientation. *Tourism Management*, *75*, 393–403. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.06.003

Mayzlin, D., Dover, Y., & Chevalier, J. (2014). Promotional Reviews: An Empirical Investigation of Online Review Manipulation. *American Economic Review*, *104*(8), 2421–2455. https://doi.org/10.1257/aer.104.8.2421

McAllister, D. J. (1995). Affect- and Cognition-Based Trust as Foundations for Interpersonal Cooperation in Organizations. *The Academy of Management Journal*, *38*(1), 24–59. https://doi.org/10.2307/256727

McCartney, M. (2009). Will doctor rating sites improve the quality of care? No. *BMJ*, *338*. https://doi.org/10.1136/bmj.b1033

McLennan, S., Strech, D., & Kahrass, H. (2018). Why are so few patients rating their physicians on German physician rating websites? A qualitative study. *BMC Health Services Research*, *18*(1), 670. https://doi.org/10.1186/s12913-018-3492-0

Mostaghimi, A., Crotty, B. H., & Landon, B. E. (2010). The Availability and Nature of Physician Information on the Internet. *Journal of General Internal Medicine*, *25*(11), 1152–1156. https://doi.org/10.1007/s11606-010-1425-7

Mudambi, S. M., & Schuff, D. (2010). Research Note: What Makes a Helpful Online Review? A Study of Customer Reviews on Amazon.com. *MIS Quarterly*, *34*(1), 185–200. https://doi.org/10.2307/20721420

Nelson, P. (1970). Information and Consumer Behavior. *Journal of Political Economy*, *78*(2), 311–329.

Nelson, P. (1974). Advertising as Information. *Journal of Political Economy*, *82*(4), 729–754.

doi:10.6342/NTU202300441

Ngo-Ye, T. L., & Sinha, A. P. (2014). The influence of reviewer engagement characteristics on online review helpfulness: A text regression model. *Decision Support Systems*, *61*, 47–58. https://doi.org/10.1016/j.dss.2014.01.011

Oh, C. S., Bailenson, J. N., & Welch, G. F. (2018). A Systematic Review of Social Presence: Definition, Antecedents, and Implications. *Frontiers in Robotics and AI*, *5*. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frobt.2018.00114

Ohanian, R. (1990). Construction and Validation of a Scale to Measure Celebrity Endorsers' Perceived Expertise, Trustworthiness, and Attractiveness. *Journal of Advertising*, *19*(3), 39–52. https://doi.org/10.1080/00913367.1990.10673191

Park, C., & Lee, T. M. (2009). Information direction, website reputation and eWOM effect: A moderating role of product type. *Journal of Business Research*, *62*(1), 61–67. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2007.11.017

Pavlou, P. A., & Dimoka, A. (2006). The Nature and Role of Feedback Text Comments in Online Marketplaces: Implications for Trust Building, Price Premiums, and Seller Differentiation. *Information Systems Research*, *17*(4), 392–414. https://doi.org/10.1287/isre.1060.0106

Peuchaud, S. R. (2020). Respected as a Client, Cared for as a Patient: Evidence of Heuristic Decision-Making from Yelp Reviews of Obstetrician-Gynecologists. *Health Communication*, *35*(7), 842–848. https://doi.org/10.1080/10410236.2019.1598613

Qiu, L., Pang, J., & Lim, K. H. (2012). Effects of conflicting aggregated rating on eWOM review credibility and diagnosticity: The moderating role of review valence. *Decision Support Systems*, *54*(1), 631–643. https://doi.org/10.1016/j.dss.2012.08.020

Rains, S. A. (2007). The Anonymity Effect: The Influence of Anonymity on Perceptions of Sources and Information on Health Websites. *Journal of Applied Communication Research*, *35*(2), 197–214. https://doi.org/10.1080/00909880701262666

Rains, S. A., & Scott, C. R. (2007). To Identify or Not to Identify: A Theoretical Model of Receiver Responses to Anonymous Communication. *Communication Theory*, *17*(1), 61–91. https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2007.00288.x

Rains, S. A., & Scott, C. R. (2022). To Identify or Not to Identify? That…Depends on the Context: Testing a Model of Receiver Responses to Anonymous Communication.

doi:10.6342/NTU202300441

Communication Reports, *35*(2), 78–91. https://doi.org/10.1080/08934215.2022.2037676

Renton, T., & Wilson, N. H. (2016). Problems with erupting wisdom teeth: signs, symptoms, and management. *The British journal of general practice: the journal of the Royal College of General Practitioners, 66*(649), e606–e608. https://doi.org/10.3399/bjgp16X686509

Rothenfluh, F., & Schulz, P. J. (2017). Physician Rating Websites: What Aspects Are Important to Identify a Good Doctor, and Are Patients Capable of Assessing Them? A Mixed-Methods Approach Including Physicians' and Health Care Consumers' Perspectives. *Journal of Medical Internet Research*, *19*(5), e6875. https://doi.org/10.2196/jmir.6875

Rothenfluh, F., Germeni, E., & Schulz, P. J. (2016). Consumer Decision-Making Based on Review Websites: Are There Differences Between Choosing a Hotel and Choosing a Physician? *Journal of Medical Internet Research*, *18*(6), e5580. https://doi.org/10.2196/jmir.5580

Schindler, R. M., & Bickart, B. (2012). Perceived helpfulness of online consumer reviews: The role of message content and style. *Journal of Consumer Behaviour*, *11*(3), 234–243. https://doi.org/10.1002/cb.1372

Schlesinger, M., Kanouse, D. E., Martino, S. C., Shaller, D., & Rybowski, L. (2014). Complexity, Public Reporting, and Choice of Doctors: A Look Inside the Blackest Box of Consumer Behavior. *Medical Care Research and Review*, *71*(5_suppl), 38S-64S. https://doi.org/10.1177/1077558713496321

Schumann, S., Klein, O., Douglas, K., & Hewstone, M. (2017). When is computer-mediated intergroup contact most promising? Examining the effect of out-group members' anonymity on prejudice. *Computers in Human Behavior*, *77*, 198–210. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.08.006

Schwartz, L. M., Woloshin, S., & Birkmeyer, J. D. (2005). How do elderly patients decide where to go for major surgery? Telephone interview survey. *BMJ*, *331*(7520), 821. https://doi.org/10.1136/bmj.38614.449016.DE

doi:10.6342/NTU202300441

Sen, S., & Lerman, D. (2007). Why are you telling me this? An examination into negative consumer reviews on the Web. *Journal of Interactive Marketing*, *21*(4), 76–94. https://doi.org/10.1002/dir.20090

Senecal, S., & Nantel, J. (2004). The influence of online product recommendations on consumers' online choices. *Journal of Retailing*, *80*(2), 159–169. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2004.04.001

Shan, Y. (2016). How credible are online product reviews? The effects of self-generated and system-generated cues on source credibility evaluation. *Computers in Human Behavior*, *55*, 633–641. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.10.013

Short, J., Williams, E., and Christie, B. (1976). *The Social Psychology of Telecommunications*. New York, NY: John Wiley.

Siering, M., Muntermann, J., & Rajagopalan, B. (2018). Explaining and predicting online review helpfulness: The role of content and reviewer-related signals. *Decision Support Systems*, *108*, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.dss.2018.01.004

Steinbrück, U., Schaumburg, H., Duda, S., & Krüger, T. (2002). *A Picture Says More Than A Thousand Words—Photographs As Trust Builders in E-Commerce Websites*. 2.

Stewart, K. J. (2003). Trust Transfer on the World Wide Web. *Organization Science*, *14*(1), 5–17. https://doi.org/10.1287/orsc.14.1.5.12810

Sun, X., Han, M., & Feng, J. (2019). Helpfulness of online reviews: Examining review informativeness and classification thresholds by search products and experience products. *Decision Support Systems*, *124*, 113099. https://doi.org/10.1016/j.dss.2019.113099

Tang, M.-C. (2016). The effect of online word of mouth on fantasy readers' preference stability: The moderating role of involvement and knowledge. *Library & Information Science Research*, *38*(4), 292–300. https://doi.org/10.1016/j.lisr.2016.11.003

Tata, S. V., Prashar, S., & Gupta, S. (2020). An examination of the role of review valence and review source in varying consumption contexts on purchase decision. *Journal of Retailing and Consumer Services*, *52*, 101734. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.01.003

doi:10.6342/NTU202300441

Terlutter, R., Bidmon, S., & Röttl, J. (2014). Who Uses Physician-Rating Websites? Differences in Sociodemographic Variables, Psychographic Variables, and Health Status of Users and Nonusers of Physician-Rating Websites. *Journal of Medical Internet Research*, *16*(3), e3145. https://doi.org/10.2196/jmir.3145

Toma, C. L. (2010). Perceptions of trustworthiness online: The role of visual and textual information. *Proceedings of the 2010 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work*, 13–22. https://doi.org/10.1145/1718918.1718923

Trehan, S. K., & Daluiski, A. (2016). Online Patient Ratings: Why They Matter and What They Mean. *Journal of Hand Surgery*, *41*(2), 316–319. https://doi.org/10.1016/j.jhsa.2015.04.018

Walther, J. B. (1992). Interpersonal Effects in Computer-Mediated Interaction: A Relational Perspective. *Communication Research*, *19*(1), 52–90. https://doi.org/10.1177/009365092019001003

Xu, Q. (2014). Should I trust him? The effects of reviewer profile characteristics on eWOM credibility. *Computers in Human Behavior*, *33*, 136–144. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.01.027

Zhang, S., Wang, J.-N., Chiu, Y.-L., & Hsu, Y.-T. (2020). Exploring Types of Information Sources Used When Choosing Doctors: Observational Study in an Online Health Care Community. *Journal of Medical Internet Research*, *22*(9), e20910. https://doi.org/10.2196/20910

Zhao, K., Stylianou, A. C., & Zheng, Y. (2018). Sources and impacts of social influence from online anonymous user reviews. *Information & Management*, *55*(1), 16–30. https://doi.org/10.1016/j.im.2017.03.006

doi:10.6342/NTU202300441

附錄一 招募文宣與招募問卷

招募文宣

大家好。我是國立台灣大學圖書資訊學研究所的碩士生，目前正在進行關於醫師評價網站的使用者行為研究，誠摯邀請年齡介於 21 - 30 歲且有使用線上評論經驗的大家參與研究。

【實驗說明】

實驗參與當日將請您操作與瀏覽實驗網站，並根據自身感受回答相關問題，實驗時長約 30-60 分鐘，確認實驗資料收集完成後，將提供您合理的實驗參與報酬。若您有意參與，請先填寫線上招募問卷，待研究者寄信與您確認參與的時間和實驗地點。

【招募條件】

1. 年齡介於 21 至 30 歲之間，性別不拘
2. 近三個月內有閱讀線上評論的經驗
3. 未參與過本研究的實驗和前測

【實驗時間】2022 年 x 月 x 日 – 2022 年 x 月 x 日

【實驗地點】國立臺灣大學 圖書資訊學系館（詳細地點會再寄信告知）

【參與者權益】

1. 研究過程收集的資料若涉及個人可辨識的資訊，將會以去識別化的方式儲存與分析。研究者會確保資料的機密與保護參與者的隱私。
2. 您可自由決定是否參加本研究，研究過程中不需要任何理由，可隨時撤回同意或退出研究。如果您拒絕參加或退出，將不會引起任何不愉快，也不會損及您的任何權利。

研究負責人：陳宇亭

聯絡方式：r09126018@ntu.edu.tw / 0921-xxx-xxx

指導教授：唐牧群教授

doi:10.6342/NTU202300441

受試者招募問卷

（1） 姓名：

_____

（2） 性別：

□ 生理男性 □ 生理女性 □ 其他____

（3） 年齡：

_____（請填寫數字，例如：22）

（4） 聯絡方式：

_____（請填寫最常收信的 email）

請閱讀以下敘述，根據你的經驗，選擇最符合的選項。

（5） 在購買產品或選擇服務前，我會上網搜尋評論，參考別人對特定產品或服務的評價

（包含：影評、書評、餐廳評論、旅館評論、線上購物產品評論等）

（1=從不，10=總是如此）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

（6）每當我要找新醫生時，我都會到網路上尋找醫生的評論

（1=從不，10=總是如此）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

doi:10.6342/NTU202300441

附錄二 實驗素材範例

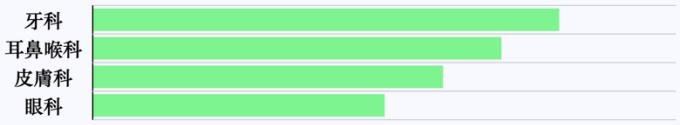
doi:10.6342/NTU202300441

1

83472654

★★★★★

醫師很專業也很細心，護士全程也都很溫和，讓從小就怕看牙醫的我感到很放鬆，大推～～～



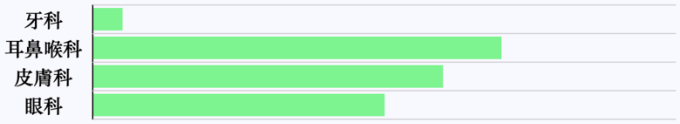
83472654 過去的評論數量與評論主題分佈

2

32661594

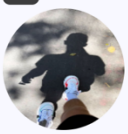
★★★★★

診所環境優美設備精良，醫護服務態度溫暖有禮，是一個舒適舒心的看診體驗！很讚大推



32661594 過去的評論數量與評論主題分佈

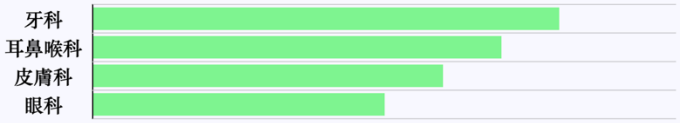
3



Lai0916

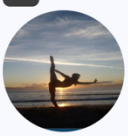
★★★★★

沒有詳細解說情況就要我們拔牙，一點專業度都沒有，態度還很差、一點同理心都沒有!



Lai0916 過去的評論數量與主題分佈

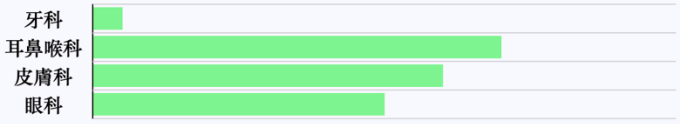
4



Yang0623

★★★★★

一般人聽到拔牙都會怕 想評估原因 問他一句他回一句 一點都沒有同理心~ 不建議大家來給他看診



Yang0623 過去的評論數量與主題分佈

doi:10.6342/NTU202300441

附錄三 研究使用量表

社會臨場感（social presence）

（測量對評論者的感知，以李克特 7 點量表測量，1=非常不同意，7=非常同意）

SP1	原文：There is a sense of human contact in the Website 翻譯調整：當我閱讀評論時，可以感覺和評論人有人際接觸
SP2	原文：There is a sense of personalness in the Website 翻譯調整：當我閱讀評論時，可以感覺到評論人的個性
SP3	原文：There is a sense of sociability in the Website 翻譯調整：**當我閱讀評論時，可以感覺到評論人的友善**
SP4	原文：There is a sense of human warmth in the Website 翻譯調整：當我閱讀評論時，可以感覺到評論人的溫度
SP5	原文：There is a sense of human sensitivity in the Website 翻譯調整：當我閱讀評論時，可以感覺到評論人人性化的特質

情感信任（affective trust）

（測量對評論者的感知，以李克特 7 點量表測量，1=非常不同意，7=非常同意）

AT1	原文：If I ask a question about purchasing a television, I feel this reviewer would respond caringly. 翻譯調整：如果我問一個關於醫生看診的問題，我覺得這位評論者會用心地回答
AT2	原文：I feel that I can talk freely with this reviewer. 翻譯調整：我覺得我可以很自在地和這位評論者交談
AT3	原文：This reviewer shows a warm and caring attitude. 翻譯調整：我覺得這位評論者很親切
AT4	原文：If I shared my concerns about a product with this reviewer, I know he would respond constructively.

doi:10.6342/NTU202300441

	翻譯調整：如果我表達我對於某位醫生的擔憂，我認為這位評論者會給予有建設性的回應
AT5	原文：This reviewer will be very open for his opinion about a product. 翻譯調整：我認為評論者會開誠佈公地表達對這位醫生的看法

認知信任（cognitive trust）

（測量對評論者的感知，以李克特 7 點量表測量，1=非常不同意，7=非常同意）

CT1	原文：I have to be cautious about acting on the advice of this reviewer because his opinions are questionable. 翻譯調整：我會對這位評論者的建議有所保留
CT2	原文：I can rely on this reviewer for suggesting a product that I am interested in. 翻譯調整：我可以依靠這位評論者給予的建議
CT3	原文：Given the information displayed on the webpage, I have no doubt about this reviewer's competence. 翻譯調整：基於網頁上呈現的資訊，我不會懷疑這位評論者的能力
CT4	原文：Given the information displayed on the webpage, I have no reservations about following the reviewer's suggestion. 翻譯調整：基於網頁上呈現的資訊，我會完全採納這位評論者的建議

選擇意向（selection intention）

（測量對醫師的選擇，以李克特 7 點量表測量，1=非常不同意，7=非常同意）

SI1	原文：The likelihood of considering this physician is: (very low to very high) 翻譯調整：我會選擇這位醫生的可能性
SI2	原文：I consider this physician a good alternative

doi:10.6342/NTU202300441

	翻譯調整：我認為這個醫生是一個不錯的選擇
SI3	原文：My willingness to shortlist this physician is: (very low to very high) 翻譯調整：我會將這位醫生列入考量

經驗能力（experience）

（用於前測衡量評論歷史顯示，以語義差異的七點量表進行測量）

EX1	原文：The writer of the review is. . . an expert/not an expert 翻譯調整：我覺得這位評論者 是專家-----不是專家
EX2	原文：The writer of the review is. . . inexperienced/experienced 翻譯調整：我覺得這位評論者對看牙醫 沒什麼經驗-----很有經驗
EX3	原文：The writer of the review is. . . unknowledgeable/knowledgeable 翻譯調整：我覺得這位評論者對看牙醫 一無所知-----非常了解
EX4	原文：The writer of the review is. . . unqualified/qualified 翻譯調整：我覺得這位評論者不夠格/夠格對牙醫發表意見
EX5	原文：The writer of the review is. . . unskilled/skilled 翻譯調整：我覺得這位評論者 不擅於撰寫評論-----擅於撰寫評論

評論可信度（perceived credibility of the reviews）

（用於前測衡量評論內容，以 1-7 點量表測量，1=非常不同意，7=非常同意）

PC1	原文：I think the message I read is factual. 翻譯調整：我認為這則評論是事實

doi:10.6342/NTU202300441

PC2	原文：I think the message I read is accurate. 翻譯調整：我認為這則評論是準確的
PC3	原文：I think the message I read is credible. 翻譯調整：我認為這則評論是可靠的
PC4	原文：I think the message I read is believable. 翻譯調整：我認為這則評論是可信的
PC5	原文：I think the message I read is trustworthy. 翻譯調整：我認為這則評論值得信賴

doi:10.6342/NTU202300441

附錄四 研究參與者知情同意書

國立臺灣大學行為與社會科學研究倫理委員會
研究參與者知情同意書

歡迎您參與本研究！此份文件名為「研究參與者知情同意書」，它將詳述您本研究之相關資訊及您的權利。在研究開始進行及您簽署本同意書之前，研究主持人或研究人員會為您說明研究內容，並回答您的任何疑問。

研究計畫名稱[5]

中文：我該相信誰？線上評論者資訊對使用者選擇醫師的影響

英文：How reviewers' profile affect viewers' trust and decision making

研究機構名稱：國立台灣大學圖書資訊學系

經費來源：自籌

研究計畫主持人：陳宇亭 **職稱：台大圖資所碩士生**

研究計畫協同主持人： **職稱：**

※研究計畫聯絡人：陳宇亭 **電話：0921-xxx-xxx**

一、研究目的：

由於參考線上醫師評價的使用者人數日漸增加，但醫師評價網站的出現及其內容的呈現，對使用者的感知和進行決策有何影響仍未被充分探索與研究。故本研究透過實驗的方式，探討此一主題，期望能透過執行此研究，對醫師評價網站上的資訊對使用者的感知和選擇決策有何影響能有更進一步的了解。

二、參與研究之條件與限制：

1. 年齡介於 21 歲至 30 歲之間
2. 未曾參與過本研究

[5] 由於計畫名稱會透露實驗內容，因此在實驗前簽署同意書時，會先移除計畫名稱。實驗結束後才向受試者說明與解釋。

doi:10.6342/NTU202300441

三、研究方法與程序：

本研究將以實驗法進行，總共會招募80位受試者參與本研究，正式實驗約需花費30–60分鐘。研究流程如下：

1. 詳閱知情同意書（此文件）之內容，並簽名
2. 抽籤決定組別與閱讀資訊
3. 閱讀情境與任務說明
4. 瀏覽此研究的實驗網站及其上的內容
5. 依指示依序填寫相關問卷
6. 研究者確認實驗完成後，將提供受試者實驗報酬

四、參與研究時之禁忌、限制及應以配合事項：

參與本研究無特殊禁忌與限制。

唯參與研究時請依照研究者的指示和說明依序進行，並保持專注。

五、研究潛在風險、發生率及救濟措施：（請說明 1. 對研究參與者有潛在之生理、心理、或個人資訊保密上之風險，或可能產生的任何不適；2.風險發生率；3. 降低風險與保護研究參與者之方法；4. 風險發生時之處理措施。）

本研究屬於微小風險研究，將不會對研究參與者造成生理、心理的風險。參與本研究無任何預期的風險或不適。但本研究仍會收集個人可辨識資料（如：姓名、email），研究計畫主持人將依法把任何可辨識您身分之紀錄與您個人隱私之資料視同機密處理，絕對不會公開。

六、研究效益與對研究參與者之益處：（1. 研究之科學效益；2 對研究參與者之益處，包含給予之報酬金額或禮品，以及參與者中途退出之計算方式等，若無亦請註明。）

研究之科學效益：對使用者評估資訊及選擇醫師決策的行為有進一步了解。

對研究參與者之益處：新臺幣/禮券 200 元，確認完成實驗後提供。若研究參與者中途退出，則不會提供研究參與者報酬，也不會使用該研究參與者的資料。

七、研究可能衍生的商業利益及其拓展應用之約定：（若無亦請註明。）

無

doi:10.6342/NTU202300441

八、研究材料保存期限、運用規劃及機密性：（含 1. 研究材料之保存期限、保存方式、運用規劃；2. 涉及可辨識之個人資訊如身分紀錄和隱私資料之機密性，及其保護與處置材料之方式。）

(一) 本研究取得您的個人資訊，將以電子檔案儲存於受密碼保護之電腦與雲端空間，僅有研究人員擁有密碼可以存取相關檔案，相關資料保存期限至 2024 年 12 月 31 日，將於期限內刪除相關檔案。

(二) 研究計畫主持人將依法把任何可辨識您身分之紀錄與您個人隱私之資料視同機密處理，絕對不會公開。將來發表研究結果時，您的身份將被充分保密。凡簽署了知情同意書，即表示您同意各項原始紀錄可直接受監測者、稽核者、研究倫理委員會及主管機關檢閱，以確保研究過程與數據，符合相關法律和各種規範要求；上述人員承諾絕對維繫您身分之機密性。

九、損害補償或保險：（含研究參與者之法定權益受損時之補償責任，若無亦請註明。）

(一) 本研究依計畫執行，參與本研究無任何預期的風險或不適，若因參與本研究而發生不良事件或損害，將由（陳宇亭）以（兩倍酬金）作為補償。除前述之補償方式，本研究不提供其他形式之補償。

(二) 您簽署本知情同意書後，在法律上的任何權利不會因此受影響。

十、研究之退出方式及處理：

您可自由決定是否參加本研究，研究過程中不需要任何理由，可隨時撤回同意或退出研究。如果您拒絕參加或退出，將不會引起任何不愉快，或影響日後研究計畫主持人對您的評價，更不會損及您的任何權利。若您決定撤回同意或退出研究，可透過（口頭或書面方式）進行，計畫主持人將會（刪除您的資料）。研究計畫主持人或研究計畫贊助或監督單位，也可能於必要時中止該研究之進行。

十一、研究參與者權利：

(一) 本研究已經過國立臺灣大學行為與社會科學研究倫理委員會審查，審查內容包含利益與風險評估、研究參與者照護及隱私保護等，並已獲得核准。委員會係依規範運作，並通過中央目的事業主管機構查核認證之審查組織。若您於研究過程中有任何疑問，或認為權利受到影響、傷害，可直接與國立臺灣大學研究倫理中心聯絡，電話號碼為：

doi:10.6342/NTU202300441

(02)3366-9956、(02)3366-9980。

(二) 研究計畫主持人或研究人員已經妥善地向您說明了研究內容與相關資訊，並告知可能影響您參與研究意願的所有資訊。若您有任何疑問，可向研究人員詢問，研究人員亦須具實回答。

(三) 研究計畫主持人已將您簽署之一式兩份同意書其中一份交給您留存。

十二、研究計畫主持人/研究人員簽名

研究計畫主持人或研究人員已詳細解釋有關本研究計畫中上述研究方法的性質與目的，以及可能產生的危險與利益。

研究人員簽名：_____

日期：_____年_____月_____日

十三、研究參與者簽名同意

本人已詳細瞭解上述研究方法及其可能的益處與風險，有關本研究計畫的疑問，已獲得詳細說明與解釋。本人同意成為本研究計畫的自願研究參與者。

研究參與者簽名：_____

日期：_____年_____月_____日

doi:10.6342/NTU202300441